18 Lo sviluppo dell'Operations Management: funzioni, strutture, ruoli[1]

di Michela Bobini, Mario Del Vecchio e Lorenzo Fenech[2]

18.1 Introduzione: L'Operations management da insieme di saperi a funzione organizzativa

Negli ultimi vent'anni si è progressivamente consolidata l'attenzione verso i processi di erogazione delle aziende nella prospettiva dell'Operations Management (OM)[3], ovvero di quell'insieme di procedure, ruoli e strumenti che presidiano il funzionamento quotidiano dei processi produttivi di un'organizzazione, intesi come la trasformazione di input in output attraverso una gestione efficace ed efficiente delle attività di servizio e di supporto (Davies & Walley, 2000; Langabeer II, 2008).

In sanità, tale prospettiva si è affermata non solo per motivi di efficienza economico-finanziaria – legati alla necessità di garantire la sostenibilità nel medio-lungo periodo in un quadro di spesa pubblica stabilizzata –, ma anche per rispondere alla crescente domanda di qualità percepita da parte di pazienti sempre più esigenti rispetto a fluidità, coerenza e valore dell'esperienza di cura. Anche la disciplina si è evoluta nel tempo: una prima fase di formalizzazione teorica sviluppata in ambito manifatturiero; una seconda che ha dato

[1] Con riferimento ai casi di studio presenti nel capitolo, si ringraziano per i preziosi contributi forniti in sede di intervista i seguenti referenti delle funzioni di OM: Roberta Irene Maria Bellini, per il caso AOU di Alessandria, Laura Di Dio, per il caso Istituto Clinico Humanitas, Eleonora Bossi, Amedeo La Cava, Daniela Gattuso e Luca Sgaria, per il caso ASST Niguarda, Jacopo Guercini e Silvia Pagliantini, per il caso AOU di Pisa. Si ringraziano inoltre Caterina Bianciardi, Clara Carbone, Jacopo Guercini, Luigi Amerigo Messina e Giovanni Poggialini per l'approfondimento sui rispettivi percorsi professionali.

[2] Nonostante il capitolo sia frutto di un lavoro di ricerca congiunto degli autori, i 18.1, 18.3, 18.4.3, 18.4.4 e 18.6 sono attribuibili a Lorenzo Fenech; i 18.2, 18.4.1, 18.4.2 e 18.5 sono attribuibili a Michela Bobini; il 18.7 è attribuibile a Mario Del Vecchio.

[3] Nel corso del capitolo si utilizzerà in maniera indistinta il termine operations management (OM), comunemente utilizzato nella pratica a livello internazionale, e gestione operativa (GO), declinazione italiana legata in particolare alla formalizzazione delle funzioni nelle aziende sanitarie.

origine al filone del "Service Operations Management", volto a riconoscere e sistematizzare le specificità dei processi nei servizi (Johnson *et al.*, 2021) e infine, una terza fase – tuttora in corso – che vede l'applicazione dell'OM al settore sanitario. Quest'ultimo passaggio, configuratosi come una vera e propria innovazione (Del Vecchio e Roma 2013), è avvenuto in modo graduale, sia sul piano teorico che nella pratica quotidiana delle aziende, e ha incontrato una serie di ostacoli strutturali, organizzativi e culturali.

Tra i principali fattori che hanno rallentato l'affermazione della prospettiva OM in sanità vi è, innanzitutto, la specificità dei processi produttivi sanitari: caratterizzati da un'elevata variabilità e imprevedibilità nella domanda, nella disponibilità delle risorse e negli esiti (Litvack e Long, 2000) e da confini organizzativi molto ampi. In una logica di "percorso", infatti, il processo di cura spesso travalica i confini aziendali e richiede un coordinamento tra attori diversi, distribuiti lungo una rete di relazioni complesse (Vissers e Beech, 2005). In secondo luogo, il governo operativo dei flussi primari – cioè la programmazione e gestione concreta delle attività cliniche e logistiche – è storicamente affidato ai dipartimenti clinici e alle loro articolazioni, dove le logiche professionali tendono a prevalere su quelle manageriali. Questo ha alimentato, in generale, una naturale prevalenza della razionalità clinica e professionale su quella operativa (Del Vecchio e Roma 2012, Fenech *et al.*, 2020). Guardare al processo con lenti operative significa adottare una prospettiva che: (i) tenga conto non solo delle attività cliniche, ma anche di tutte le fasi che accompagnano il percorso del paziente (es. prenotazione, attese, ritiro referti); (ii) consenta di accostare attività e servizi anche clinicamente distanti, ma gestionalmente simili (come nel caso delle aree outpatient multi-specialistiche o del day surgery); e (iii) permetta di valutare l'efficienza operativa, la tempestività dei processi e l'esperienza di consumo accanto alla loro efficacia clinica. Si tratta, evidentemente, di un passaggio culturale ancor prima che tecnico (Fenech, 2022). Nonostante queste "barriere naturali", è ormai più di vent'anni che a livello internazionale si è consolidato l'Health Operations Management (HOM) come disciplina che fornisce chiavi di lettura, metodi e strumenti testati nella realtà per l'analisi, il governo e la riprogettazione dei processi (Vissers e Beech 2005, Karuppan *et al.*, 2021). Tra gli obiettivi riconosciuti vi sono: ridurre i costi, ridurre la variabilità gestionale, migliorare il flusso logistico, migliorare la produttività, migliorare la qualità del servizio fornito e migliorare continuamente il funzionamento dei processi (Pellegrini *et al.*, 2025). Nel mentre la disciplina "come approccio" e "insieme di strumenti" si evolve per rinnovarsi (es: "Behavioural Operations") e per far fronte alle sfide del nuovo millennio (andamento demografico, tecnologie, ecc.), rimane in generale ancora poco esplorata la questione di come e se questo insieme di saperi debba essere allocato a dei "ruoli" e funzioni ad hoc. Si tratta di un tema che era stato già sollevato da Del Vecchio e Roma nel 2012 che segnalavano come all'epoca fosse prematuro ragionare sulle strutture organizzative prima che l'OM, inteso come

nuova chiave interpretativa degli accadimenti aziendali, fosse stato metabolizzato dalle aziende. La sfida del se e come costruire un'infrastruttura organizzativa capace di diffondere e rendere sistematiche le competenze operative nei diversi livelli aziendali è oggi tanto urgente quanto complessa e, a tratti, confusa.

È urgente perché la stretta sulle risorse impone un irrobustimento delle leve aziendali per una razionalizzazione delle operazioni aziendali. Seppur ancora scarse, le prime evidenze sembrano confermare l'apporto positivo delle funzioni di OM in questa direzione (Fenech *et al.*, 2018 e Pellegrini *et al.*, 2025). Bisogna comunque premettere che è possibile sviluppare un approccio di OM senza necessariamente avere una funzione e un ufficio specificatamente preposto e utilizzando altre leve per una sua diffusione organica in azienda (formazione, prassi organizzative, gruppi di lavoro, ecc.). In questo senso anche la sola formalizzazione di "Operations Meetings" può rivelarsi adeguata ed efficace, come suggerito da Sutton *et al.* (2025). Dal punto di vista dell'OM come disciplina il momento è favorevole perché le pressioni esterne, il consolidamento scientifico dell'HOM, la formazione diffusa e la condivisione di pratiche tramite eventi come il "Lean Award" hanno, di recente, contribuito a sdoganare la prospettiva dell'OM sul piano culturale (pur non riducendo ancora completamente le barriere), gettando le premesse necessarie per la costituzione di vere e proprie funzioni. Nel momento in cui si opta per la strutturazione di una funzione di operations il percorso è più complesso perché alla questione dello scontro culturale si aggiunge anche quello di "potere" sul governo dei fattori produttivi (tempi e ritmi di lavoro delle persone). Inoltre, la questione relativa ai confini organizzativi e alla formalizzazione della funzione di Operations Management (OM) rimane poco definita, riflettendo una più ampia incertezza che caratterizza anche altri settori dei servizi. Come osservano Slack *et al.* (2019), nella pratica "non sempre le persone che supervisionano la creazione e l'erogazione di un servizio sono chiamate operations managers, anche se di fatto lo sono". Tale ambiguità è efficacemente sintetizzata dal titolo del volume di Secchi (2025), "Operations Managers: protagonisti o comparse?", mentre Belvedere (2014) evidenzia come, nei contesti di servizio, la responsabilità sulle operations risulti fisiologicamente diffusa e difficilmente circoscrivibile.

In continuità con i contributi precedenti del Rapporto OASI sul tema (Giusepi *et al.*, 2012; Fenech *et al.*, 2018), il presente capitolo si propone di aggiornare l'osservazione e l'analisi delle funzioni di OM nelle aziende sanitarie, a oltre un decennio dalle prime esperienze di istituzione e consolidamento. Sebbene le traiettorie evolutive delle funzioni siano ancora molto eterogenee e frammentate, l'obiettivo generale è quello di valorizzare il patrimonio di competenze sviluppato nel tempo da aziende e professionisti che hanno investito in questo ambito al fine di trarre indicazioni utili sulle possibili interpretazioni organizzative ("idealtipi"), sui vantaggi e svantaggi di ciascun sugli impatti organizzativi e sui fattori che ne condizionano la piena istituzionalizzazione.

18.2 Obiettivi e metodologia

In particolare, il lavoro si propone di rispondere a due principali domande di ricerca:

- Come si è evoluta la funzione di OM nelle aziende sanitarie e quali ruoli e assetti organizzativi tende oggi ad assumere? Questa domanda mira a indagare in che modo la funzione di OM si stia consolidando come componente organizzativa stabile e riconosciuta e come si stiano ridefinendo i suoi confini operativi e decisionali.
- Quali prospettive e sfide si delineano per lo sviluppo e il consolidamento della funzione di OM nel medio periodo? Questa seconda domanda intende approfondire le condizioni che favoriscono o ostacolano la maturazione della funzione, analizzando: i fattori abilitanti che ne sostengono l'evoluzione e la capacità di generare valore; le barriere organizzative, culturali e professionali che ne limitano la piena istituzionalizzazione; le strategie di sviluppo necessarie per rafforzarne il posizionamento e il contributo ai processi di governo aziendale.

Per rispondere alle domande di ricerca è stato adottato un approccio qualitativo, articolato su tre livelli:

- definizione di un *framework* di analisi per l'identificazione delle dimensioni delle funzioni oggetto di indagine;
- analisi di quattro casi studio aziendali caratterizzati da una funzione di OM relativamente matura, condotta attraverso interviste semi-strutturate ad almeno un *key informant* per ciascun caso, per un totale di 6 referenti, e analisi desk dei siti web aziendali;
- raccolta del parere di esperti della funzione con esperienze pluriennali in più contesti aziendali, mediante interviste semi-strutturate volte ad arricchire il quadro delle esperienze e la lettura critica delle evidenze complessivamente raccolte.

Il primo step si rende necessario visti i confini ampi e spesso confusi in materia di OM e in particolar modo sulle funzioni organizzative ad esso associate.

La scelta poi del metodo del caso studio risponde all'esigenza di esplorare in profondità fenomeni ancora in evoluzione, caratterizzati da traiettorie organizzative non lineari e da forti specificità di contesto. Le funzioni di OM presentano, infatti, sviluppi spesso "carsici", che richiedono uno sguardo analitico sulle dinamiche interne e sulle interdipendenze tra livelli organizzativi. La selezione dei casi si è basata su due criteri principali: i) ambito ospedaliero, considerato il più fertile per lo sviluppo delle funzioni di OM grazie alla presenza di asset

produttivi ben definiti (sale operatorie, posti letto, percorsi clinici complessi); ii) grado minimo di maturità, fissato in almeno sei anni dalla formale istituzione della funzione. Sono state quindi individuate quattro realtà con percorsi di sviluppo differenti:

- IRCCS Humanitas Research Hospital di Rozzano, dove la funzione nasce con l'atto costitutivo aziendale e rappresenta un riferimento nazionale;
- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, in cui la funzione viene istituita nel 2017 su impulso regionale e consolida un percorso di crescita strutturale;
- Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa, in cui spinte bottom-up si integrano con politiche regionali di rafforzamento organizzativo;
- Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria, dove la funzione si sviluppa progressivamente attorno a iniziative interne.

Questi casi aziendali sono stati ripresi e approfonditi da prospettive differenti anche nei capitoli 3 e 16 del presente Rapporto. Si rimanda agli stessi per ulteriori approfondimenti.

A integrazione dei casi, sono state condotte cinque interviste in profondità a professionisti con esperienza consolidata nella direzione o sviluppo di funzioni di OM in differenti contesti aziendali e regionali. La selezione degli esperti è stata guidata dall'obiettivo di includere figure che avessero ricoperto ruoli apicali o di responsabilità diretta nella funzione, che avessero operato in più organizzazioni sanitarie, così da offrire una prospettiva comparativa, e che avessero contribuito alla diffusione del paradigma dell'Operations Management in sanità anche attraverso attività di formazione, ricerca o partecipazione a reti professionali. La Tabella 18.1 riporta una sintesi dei profili degli esperti intervistati, specificando per ciascuno il background formativo e le esperienze più significative maturate nel corso della propria attività professionale in ambito di OM.

Attraverso i loro percorsi è stato possibile ricostruire la varietà dei modelli organizzativi adottati e le strategie utilizzate per integrare la dimensione operativa con quelle clinico-assistenziale, economico-finanziaria e tecnologica. Le loro testimonianze hanno offerto un contributo interpretativo rilevante per identificare le competenze emergenti, le condizioni abilitanti e le criticità che ancora limitano il pieno riconoscimento della OM come leva strategica per il governo dell'erogazione.

Il capitolo è articolato in quattro sezioni principali che accompagnano il lettore in un percorso progressivo, dal livello descrittivo dei casi empirici a quello interpretativo e di sintesi. Il 18.3 introduce il *framework* di analisi e illustra

Tabella 18.1 **L'identikit degli esperti: background formativo ed esperienze in ambito di OM**

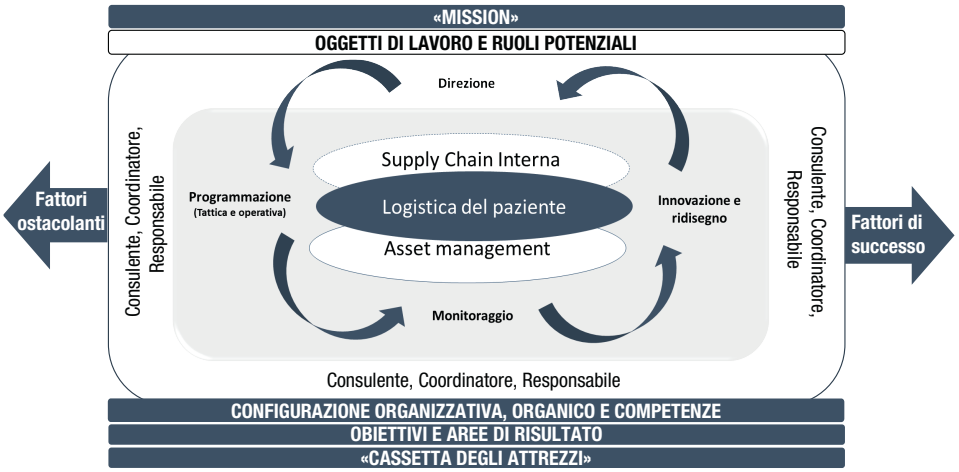
Background formativo	PRINCIPALI ESPERIENZE IN AMBITO DI FUNZIONI DI OPERATIONS MANAGEMENT
Economia aziendale	Ha consolidato la funzione di OM presso l'ASST Nord Milano, conducendola fino alla formalizzazione come Struttura Complessa; attualmente dirige l'Area Accessi e CUP dell'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano.
Ingegneria biomedica	Ha avviato e diretto funzioni di OM in diverse aziende sanitarie del Nord Italia, tra cui ASL Biella, ASST Sette Laghi di Varese e ASST di Brescia, con responsabilità nell'impostazione e gestione di strutture integrate di Operations.
Ingegneria gestionale	Ha maturato esperienza come Operations Manager presso l'AOU Senese e l'AOU di Alessandria, fino alla direzione di una Struttura Complessa di GO presso l'AOU di Bologna – Policlinico S. Orsola.
Ingegneria gestionale	Ha operato nell'Ufficio Lean dell'AOU Senese e in ambito Operations presso il Policlinico IRCCS San Martino, attualmente è Direttore UOC Controllo di Gestione e Gestione Operativa Outpatient dell'AOUP.
Ingegneria gestionale	Ha contribuito alla fondazione e allo sviluppo di strutture di OM in diversi contesti lombardi (ATS Monza, San Gerardo, ASST Santi Paolo e Carlo) ed è attualmente responsabile della Struttura Complessa di GO presso la Fondazione IRCCS Ca' Granda – Policlinico di Milano.

le dimensioni di osservazione che guidano la lettura dei casi. Il 18.4 riporta i risultati dell'analisi condotta su quattro aziende sanitarie individuate come casi rappresentativi di modelli di OM "maturi". I 18.5 e 18.6 sviluppano una discussione trasversale dei risultati, integrando le evidenze empiriche con le riflessioni emerse dalle interviste agli esperti. Tale analisi comparativa consente di individuare *pattern* ricorrenti, differenze di impostazione e traiettorie evolutive, e conduce alla formulazione di un *framework* interpretativo volto a descrivere le diverse posture organizzative che la funzione di OM può assumere all'interno delle aziende sanitarie. Infine, il 18.7 propone alcune riflessioni conclusive, mettendo in luce gli apprendimenti principali e delineando le prospettive di sviluppo della funzione, le sfide ancora aperte e le condizioni abilitanti per il suo consolidamento quale leva strategica nel governo dei processi di erogazione.

18.3 Il *framework* di analisi

In questo paragrafo si propone un *framework* di analisi utilizzato per identificare e inquadrare le dimensioni fondamentali per la progettazione delle funzioni di operations management nelle aziende sanitarie (Figura 18.1). Il *framework* combina il quadro definitorio dell'OM in generale di Slack *et al.* (2019) con il focus che emerge dalla letteratura sull'OM in sanità e gli spunti sugli assetti organizzativi dell'OM degli ultimi rapporti OASI. Le dimensioni di analisi identificate sono i) Mission ii) Oggetti di lavoro iii) Ruolo iv)

Figura 18.1 ***Framework* di analisi: dimensioni di indagine**



Fonte: a cura degli autori su Slack *et al.* (2019) e Fenech *et al.* (2018)

Configurazione organizzativa (assetto, organico e competenze) v) Aree di risultato vi) Metodi, strumenti e leve organizzative vii) Fattori facilitanti e ostacolanti.

Mission

Come anticipato nell'introduzione, la funzione di OM in sanità si è storicamente sviluppata come risposta pragmatica alla crescente complessità operativa degli ospedali, con una missione inizialmente centrata sulla continuità operativa e sull'efficienza nell'uso delle risorse. Obiettivi come la razionalizzazione dei flussi, il contenimento dei costi e l'ottimizzazione della logistica interna hanno a lungo guidato il suo sviluppo (Del Vecchio e Roma, 2013, Giusepi *et al.*, 2012, Fenech *et al.*, 2017 e 2018, Pellegrini *et al.*, 2025).

Oggetti di lavoro

Per oggetti di lavoro ci si riferisce alla tipologia di processi o elementi del processo (logistica del paziente, *asset management*, *supply chain* interna beni e informazioni) oppure alle *pipeline* produttive (outpatient vs inpatient, emergenza vs elezione). Le analisi fin qui condotte hanno mostrato come le funzioni strutturate di OM in fase di *start up* in ambito ospedaliero si sia concentrata sulla logistica dei pazienti e sulla gestione degli *asset*, con particolare riferimento alla *pipeline* inpatient (ottimizzazione utilizzo posti letto e sale operatorie, miglioramento flussi percorso medico urgenza e programmazione elezione). Uno studio recente segnala come gli oggetti delle funzioni di OM si stiano ampliando a tutte le *pipeline* produttive (Pellegrini *et al.*, 2025).

Il ruolo
Vengono considerati tre elementi. Da una parte, ci si riferisce all'estensione del coinvolgimento nei processi decisionali che caratterizzano il funzionamento e la progettazione della "produzione". Riprendendo le classiche definizioni di operations management si tratta delle seguenti attività (Slack *et al.*, 2019, Bensa *et al.*, 2008):

- Direzione (definizione degli obiettivi e alta supervisione);
- Programmazione (tattica e operativa) di volumi e asset;
- Gestione quotidiana di flussi e asset;
- Progettazione: innovazione e/o standardizzazione dei processi.

Dall'altra c'è il tema dell'intensità del coinvolgimento e la responsabilizzazione sui risultati di tali attività che possiamo distinguere sinteticamente in tre livelli:

- Bassa – Consulente: supporto ai processi decisionali
- Media – Coordinatore: partecipazione attiva e coordinamento dei processi decisionali
- Alta – Responsabile: responsabilizzazione sui risultati

Infine, vi è l'influenza sui processi di produzione che è il combinato disposto delle due sopra. Dai contributi precedenti emerge come la G.O. nasca tipicamente come "tecnostruttura" (Mintzberg, 1992) in staff alla direzione strategica e, pertanto, resti inizialmente fuori dalla catena gerarchica e decisionale, con un focus sulla riprogettazione e standardizzazione dei processi e un grado di responsabilizzazione medio-basso (progetti tipicamente top down e ruolo di project manager o formatore). Dunque nelle fasi iniziali esercita principalmente un'influenza indiretta e relativamente debole sui processi di produzione. L'operazione di centralizzazione della programmazione degli asset e il coinvolgimento della G.O. nei processi decisionali della programmazione tattica e talvolta anche operativo ne ha esteso e rafforzato il ruolo (Rapporto OASI 2018).

Le configurazioni organizzative, organico e competenze
Possono essere molteplici e variegate (Rapporto OASI 2017): Unità Operativa (semplice, semplice dipartimentale, complessa), Funzione, Ufficio, Area Funzionale o meccanismo organizzativo (gruppi di lavoro, programma, ecc.). Si tratta comunque tipicamente di funzioni di staff al direttore generale, direttore sanitario o amministrativo, con una prevalenza dei primi due. Dall'approfondimento dei casi aziendali proposto nel rapporto OASI 2018 emergono poi delle differenziazioni anche all'interno delle stesse Unità Organizzative della stessa tipologia. L'approfondimento aveva mostrato anche delle differenze nella scelta dei responsabili e nella dimensione e skill-mix degli organici, con una gestione

operativa più a trazione infermieristica, una a trazione medica ed altre a trazione ingegneristica. A questo si associava un differente percorso di sviluppo della funzione in termini di approccio o priorità. Tre casi su quattro presentavano comunque team-multidisciplinari, un tema rilevato anche nel contributo del 2012 di Giusepi *et al.* e confermata dallo studio di Pellegrini *et al.* (2025).

La cassetta degli attrezzi e le leve gestionali.
Ci si riferisce, in questo caso, ai tipici strumenti dell'OM: il *process mapping* (per l'analisi del ciclo della programmazione e per la fase di pre-ricovero), l'analisi statistica della casistica (variabilità casistica urgente vs programmata) e la rilevazione e analisi sistematica dei dati (per definire standard e monitorare la gestione, ecc.). Dalle analisi precedenti risultano presenti, ma meno diffusi (Pellegrini *et al.*, 2025) strumenti che richiedono competenze avanzate di Ricerca Operativa e un adeguato supporto Informativo (Statistical Process Control, Modelli di Simulazione, la Teoria delle Code) nonché alcune pratiche tipiche del Lean Thinking (Six Sigma, Visual Management).

Obiettivi di risultato e metriche di riferimento.
Dai contributi precedenti la dimensione di performance più rappresentata risulta essere quella relativa alla produttività/efficienza e alla fluidità dei processi. Tra gli indicatori più diffusi e regolarmente monitorati vengono segnalati i tipici indicatori di efficienza operativa ospedaliera quali la degenza media, i tassi di utilizzo degli asset, l'indice di rotazione (Pellegrini *et al.*, 2025). Vi sono poi indicatori di governo dell'offerta in termini di supporto all'appropriatezza dell'offerta (es: il tasso di procedure che rispettano le classi di priorità). Infine, ci sono aree che hanno a che fare con l'implementazione dei percorsi di innovazione come il tasso di adesione a una nuova procedura operativa (es: pre-ricovero centralizzato) o il tasso di digitalizzazione dei processi (Fenech *et al.*, 2018). Come notano Pellegrini *et al.* (2025), le aree di risultato fin qui esposte limitano le funzioni di OM al "supporto del buon funzionamento delle singole aree produttive, con una visione ancora poco strategica e di creazione di valore".

Fattori ostacolanti e facilitanti
Fenech *et al.* nel rapporto OASI 2018 identificano tre spinte allo sviluppo della funzione di OM: l'isomorfismo coercitivo, normativo e mimetico. Si rimanda a tale capitolo per una disamina approfondita. Qui basta richiamare come il primo sia legato a una sorta di imposizione "top down" attraverso, ad esempio, direttive regionali (es: Lombardia: obbligo di introduzione della funzione nell'organigramma). Il secondo si riferisce al cambiamento legato alla condivisione di valori e prospettive simili per via di un continuo scambio interno di professionisti e momenti di condivisione di pratiche (es: *network* regiona-

li e *benchmarking)*. La terza spinta avviene per imitazione spontanea di casi di successo da parte di alcune strutture. Aldilà delle spinte legate a fattori di contesto, i precedenti rapporti OASI hanno visto nella figura del DG la figura chiave a livello aziendale per l'istituzione e lo sviluppo della funzione. Dall'altra parte, gli studi precedenti sottolineano una serie di ostacoli che possono frenare l'introduzione o il buon funzionamento di una gestione operativa: le resistenze interne al cambiamento sia dei professionisti sulla line produttiva che delle funzioni contendibili (Direzioni Mediche di Presidio, Controllo di Gestione…). Infine, la letteratura sottolinea l'indisponibilità di dati affidabili per un efficace governo dei flussi dei pazienti (Pellegrini *et al.*, 2025).

18.4 Le funzioni di Operations Management (alias Gestione Operativa): evidenze dai casi aziendali

Il presente paragrafo raccoglie i risultati dell'analisi empirica condotta su quattro aziende sanitarie – IRCCS Humanitas Research Hospital, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, AOU Pisana e AOU di Alessandria – individuate come contesti rappresentativi di funzioni di OM mature. La Tabella 18.2 offre una visione comparativa di sintesi dei casi, evidenziando le principali dimensioni analitiche considerate: la genesi della funzione, gli assetti organizzativi, le responsabilità e gli ambiti progettuali. Questa lettura trasversale consente di cogliere rapidamente somiglianze e differenze tra modelli, anticipando gli approfondimenti di dettaglio presentati nei paragrafi successivi.

18.4.1 IRCCS Istituto Clinico Humanitas

L'Istituto Clinico Humanitas, situato a Rozzano alle porte di Milano, rappresenta il polo clinico e scientifico di riferimento del Gruppo Humanitas. Nato nel 1996 e riconosciuto come IRCCS nel 2005, l'ospedale è stato fin dall'inizio concepito come un ecosistema integrato di assistenza, ricerca e didattica. Il presidio ospedaliero si estende su una superficie di oltre 230.000 metri quadrati e dispone oggi di 759 posti letto, che includono day hospital, MAC e 28 letti di terapia intensiva. L'area chirurgica è composta da 45 sale operatorie, a cui si affiancano circa 200 ambulatori. A garantire il funzionamento di questa azienda complessa contribuiscono quotidianamente più di 4.000 professionisti (inclusi i ricercatori).

La funzione di GO ha radici profonde, che coincidono con l'apertura stessa dell'ospedale nel 1996. Sin dalla sua nascita, Humanitas è stata concepita secondo una logica di efficienza strutturale, ottimizzazione degli impianti e massima valorizzazione degli *asset* fisici, come sale operatorie, aree ad alta intensità tecnologica e impianti di sterilizzazione. Questa visione, derivata dall'esperienza del gruppo in ambito siderurgico e di costruzione di grandi im-

Tabella 18.2 **Visione comparativa dei casi studio aziendali**

Dimensioni di analisi	IRCCS Humanitas	ASST Niguarda	AOUP Pisa	AOU Alessandria
Genesi della funzione di GO	• 1996 avvio e formalizzazione	• 2017 avvio • 2021 formalizzazione	• 2010 avvio • 2011 formalizzazione	• 2009 avvio • 2021 formalizzazione
Configurazione organizzativa	• Direzione Operativa risponde al DG • Due aree: (i) programmazione e monitoraggio produzione (ospedaliera e ambulatoriale); (ii) progetti e sviluppo PDTA • Team: 13 unità con background economico, ingegneristico, umanistico • CdG verifica fattibilità economico-finanziaria delle progettualità sviluppate	• GO UOC in staff alla DG • Gruppo aree: (i) SS Sale Operatorie, (ii) Area Ambulatoriale, (iii) Ufficio RUA–tempi di attesa;iv) Area bed management e pronto soccorso, v) Operations (progettualità trasversali) • Team di 14 professionisti + 1 Direttore con background economico, ingegneristico, medico e infermieristico • Relazioni con DS e direzioni di presidio, governance condivisa	• UOC Innovazione e Sviluppo per area Inpatient che include l'area Visual Hospital con personale dedicato • UOC Controllo di Gestione per Area outpatient • Team inpatient: 11 unità con background economico, ingegneristico, medico e infermieristico • Team outpatient (7 unità sanitarie e amministrative) in linea con il CdG e due ingegneri	• UOS GO all'interno della UOC ASSIO, Area Sviluppo Strategico e Innovazione organizzativa, in staff alla Direzione Amministrativa. • La funzione ASSIO comprende il Controllo di Gestione, Processi Amministrativi, Qualità e Accreditamento. • Team della GO: 3 unità con background economico, clinico e ingegneristico. Team di ASSIO: oltre 70 unità.
Ruolo della GO rispetto alle attività tipiche dell'operations				
Direzione	Responsabile	Co-responsabile	Co-responsabile e consulente	Consulente
Pianificazione volumi e capacity	Responsabile e coordinatore	Co-responsabile e coordinatore	Responsabile e coordinatore	Consulente
Programmazione tattica	Responsabile	Co-responsabile e coordinatore	Co-responsabile e coordinatore	Coordinatore e Consulente
Programmazione operativa	Responsabile	Coordinatore	Co-responsabile	Consulente
Gestione Asset e flussi	Responsabile	Coordinatore	Co-responsabile e consulente	Consulente
Innovazione dei processi	Responsabile e consulente	Responsabile	Responsabile e consulente	Consulente e coordinatore
Oggetti prevalenti	• Logistica del paziente sia area inpatient che outpatient	• Logistica del paziente sia area inpatient che outpatient	• Logistica del paziente sia area inpatient che outpatient	• Logistica del paziente sia area inpatient che outpatient

pianti produttivi a livello internazionale, ha guidato la definizione iniziale della funzione di GO come "ingegneria di produzione in sanità", con l'obiettivo di garantire un utilizzo flessibile, sostenibile e misurato degli *asset*. La Direzione Operativa di Humanitas è inquadrata direttamente sotto la Direzione Generale. La struttura si articola internamente in due aree funzionali. La prima è deputata alla programmazione e al monitoraggio delle attività produttive, sia in ambito ospedaliero che ambulatoriale. Questo ambito presidia la pianificazione e programmazione delle agende ambulatoriali e delle sale operatorie, la pianificazione a lungo termine della capacità produttiva, il controllo dei flussi e la costruzione di sistemi indicatori per il governo dell'efficienza, con particolare attenzione all'equilibrio tra domanda e accessibilità dei pazienti, risorse disponibili e vincoli di sostenibilità. La seconda area è focalizzata sullo sviluppo progettuale trasversale e supporta l'evoluzione dei percorsi clinici. In questo ambito si concentrano le attività di co-progettazione e revisione dei PDTA oncologici in collaborazione con i Tumor Board e i board clinici delle diverse aree, il supporto all'organizzazione e ai flussi di Pronto Soccorso, i progetti di innovazione digitale, le azioni di miglioramento continuo rispetto alla patient experience. tutte le azioni di miglioramento continuo sono svolte in sinergia con la Direzione Qualità e Sanitaria.

Configurazione organizzativa e organico

La funzione di GO si avvale di un team composto da 13 professionisti, allocati nei due ambiti: 10 persone dedicate alla programmazione e al monitoraggio delle attività inpatient e outpatient e un nucleo più ristretto (3 persone) impegnato nello sviluppo delle attività progettuali, con particolare riferimento ai PDTA oncologici. La composizione del team riflette l'evoluzione della funzione stessa: originariamente centrata su profili con *background* in ingegneria gestionale (oggi 5 professionisti), la struttura ha progressivamente ampliato il proprio spettro di competenze, includendo figure con formazione economica (6) e umanistica (2). Tra queste ultime si annoverano professionisti con Laurea in Psicologia o Lettere, successivamente formatisi in ambito economico-gestionale attraverso master e percorsi post-laurea. Il Controllo di Gestione, pur collocato in staff alla Direzione Generale, svolge un ruolo complementare e sinergico, fungendo da presidio analitico e da verifica economico-finanziaria delle progettualità sviluppate. Le attività della Direzione Operativa vengono monitorate settimanalmente attraverso incontri congiunti con le altre direzioni, nell'ambito dei quali si analizzano l'andamento dei progetti e l'allineamento ai target di efficacia e sostenibilità. Le relazioni più strette si instaurano con la Direzione Sanitaria, che presidia gli ambiti di qualità e innovazione clinica e riporta anch'essa direttamente all'Amministratore Delegato. Rilevanti sono anche i rapporti con la Direzione Infermieristica, la Direzione Risorse Umane – con la quale collabora nella definizione degli organici e nella gestione

delle competenze – e con le funzioni di Servizio Clienti, Logistica, Qualità, IT, Supply Chain e Comunicazione. L'attività della Direzione di GO si fonda su un monitoraggio costante dei dati di performance – saturazione, puntualità, annullamenti, tempi di attesa, follow-up – e sull'impiego sistematico di indicatori di qualità ed efficienza. Accanto a ciò, la funzione condivide con le UO la responsabilità del budget delle attività assistenziali, contribuendo alla sostenibilità economica complessiva dell'azienda.

Ruolo, responsabilità e obiettivi della funzione
Gli obiettivi della funzione sono definiti annualmente e articolati per area e per livello di responsabilità. Il responsabile della funzione viene valutato sul raggiungimento degli obiettivi di qualità clinica, di *patient experience* e di quelli di risultato economico generale, in particolare in termini di ritorno sugli investimenti e sostenibilità della produzione. I membri del team, a loro volta, sono destinatari di obiettivi specifici, declinati in funzione del ruolo svolto: chi presidia le attività programmatiche lavora su KPI di saturazione, utilizzo degli asset, puntualità e gestione della domanda; chi si occupa di progettualità è valutato sul completamento e l'impatto dei progetti trasversali; chi segue percorsi clinici contribuisce alla qualità del servizio erogato, monitorata anche attraverso indicatori di processo e di esito. Tutti gli obiettivi includono una componente legata alla qualità percepita dal paziente e si fondano su una logica di corresponsabilità, che prescinde da leve gerarchiche dirette, ma si basa su legittimazione funzionale e riconoscimento trasversale. Nel complesso, la Direzione Operativa ha consolidato un ruolo centrale nella gestione della capacità produttiva, contribuendo in modo misurabile all'organizzazione efficiente dei flussi, alla razionalizzazione dell'uso delle tecnologie e alla flessibilità dell'offerta clinica. I risultati ottenuti – in termini di saturazione, puntualità, tempi di accesso e contenimento degli sprechi – confermano la capacità della funzione di operare come leva strategica per il governo sostenibile delle attività ospedaliere.

Principali progettualità e risultati
Nel corso degli ultimi anni, la Direzione Operativa di Humanitas ha promosso e implementato una serie di progettualità trasversali, finalizzate all'ottimizzazione degli asset produttivi, alla sostenibilità delle attività assistenziali e al miglioramento dell'esperienza del paziente. Di seguito si presentano alcune delle principali progettualità attivate.

- *Area chirurgica.* In ambito chirurgico, la GO ha implementato modelli di programmazione basati su cicli standardizzati e segmentazione per cluster omogenei. La funzione coordina i tavoli di lavoro sulla produttività dei blocchi operatori e della centrale di sterilizzazione. In questi tavoli sono rappresentate, oltre agli operatori (caposala, responsabili anestesisti, chirurghi su

temi specifici), le funzioni aziendali più direttamente coinvolte sul funzionamento dei servizi: Direzione Risorse Umane, Direzione Sanitaria e Qualità. In questi tavoli di lavoro si punta a ridurre i rischi e aumentare la produttività (es. numero interventi per seduta, % casi sospesi) partendo dal migliorare la programmazione chirurgica e arrivando fino ad ottimizzare il percorso dei materiali e del paziente nell'ospedale.

- *Area medica.* Per ridurre la pressione sul sistema dei ricoveri e contenere il fenomeno del *boarding*, sono state attivate linee ambulatoriali dedicate a pazienti non critici (medicina interna, diagnostica accessibile in 24/48h), percorsi domiciliari post Pronto Soccorso e strumenti organizzativi di triage per l'indirizzamento verso setting a bassa intensità. A fronte di circa 51.000 accessi annui al Pronto Soccorso, queste iniziative hanno contribuito a ridurre il ricorso ai ricoveri inappropriati e ad aumentare la tempestività della presa in carico chirurgica.
- *Area ambulatoriale*. La Direzione di GO presidia l'allocazione delle agende e il bilanciamento tra attività SSN e private. Negli anni l'attività garantisce un aumento della saturazione ambulatoriale, con valori compresi tra l'84% e il 100% in alcune macro-aree e una riduzione dei gap tra potenziale e capacità effettiva fino al 20%. È stato inoltre garantito un accesso preferenziale per i follow-up oncologici e avviato lo sviluppo di nuovi servizi ambulatoriali in logica di Medical Care sul territorio.
- *Asset Management Complessivo.* Humanitas ha intrapreso un ampio progetto di riorganizzazione strutturale, che ha interessato circa il 60% della superficie ospedaliera. L'intervento ha previsto l'utilizzo di componenti modulari e materiali leggeri per consentire modifiche rapide e adattive, in linea con l'evoluzione della domanda clinica. La Direzione Operativa coordina direttamente la progettazione dei nuovi *layout* e la gestione logistica dei trasferimenti. Nel 2025, la funzione ha gestito l'apertura di un nuovo edificio, curando la riallocazione di attività e personale.
- *Percorsi Complessivi.* La GO ha dovuto affrontare la crescente complessità e variabilità dei percorsi clinici supportando attivamente la definizione di nuovi PDTA e il loro incardinamento operativo nei processi di prenotazione e programmazione. Attualmente sono attivi più di una decina di percorsi formalizzati, relativi a patologie oncologiche (mammella, colon, fegato, polmone, prostata) e a cronicità non oncologiche ad alta intensità, tra cui scompenso cardiaco, malattie reumatologiche ed epatopatie. La Direzione Operativa interviene su tutte le fasi del percorso – dalla stima della domanda alla definizione dei punti di contatto organizzativi – con l'obiettivo di garantire appropriatezza, continuità e sostenibilità. L'adozione di modelli *all-in-one-day* ha ridotto significativamente gli accessi multipli, mentre la saturazione delle agende PET ha raggiunto il 96%, migliorando l'efficienza dell'uso delle tecnologie diagnostiche.

18.4.2 ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Inaugurato nel 1939, ASST Niguarda ha progressivamente ampliato e riorganizzato le proprie attività, con un'accelerazione significativa nell'ultimo decennio, in cui si è investito in interventi strutturali, tecnologie avanzate e revisione dei modelli organizzativi. A seguito della riforma del sistema sanitario lombardo del 2016, Niguarda ha esteso il proprio perimetro operativo includendo anche l'erogazione di servizi di assistenza territoriale, con l'obiettivo di favorire la continuità della presa in carico. La struttura si estende su 322.000 mq e comprende 40 sale operatorie, oltre 70 reparti, 350 ambulatori e 1.167 posti letto. L'organico è composto da circa 5.314 operatori, di cui circa 1.072 medici e oltre 2.993 tra infermieri, tecnici sanitari, ostetriche e riabilitatori.

Configurazione organizzativa, organico e integrazione inter-funzionale
La funzione di GO era stata già censita dal Rapporto OASI 2017 e posta tra le realtà pionieristiche nell'istituzionalizzazione della funzione in Lombardia. Nella sua fase iniziale prevedeva la presenza di due strutture dedicate: l'Ufficio "Gestione Operativa Processi", collocato all'interno della UOC "Accoglienza, Marketing e Area Privata" sotto la Direzione Amministrativa e la Funzione "Gestione Operativa Sociosanitaria", afferente alla Direzione Sociosanitaria. Entrambe le strutture presidiavano ambiti chiave quali la logistica dei pazienti, la gestione delle piattaforme produttive (sale operatorie, posti letto, ambulatori) e, in parte, la *supply chain*. A partire dalla seconda metà del 2021, la funzione di GO è stata formalizzata nell'organigramma aziendale come una struttura complessa rispondente direttamente alla Direzione Generale, in risposta a un impulso regionale che, nel contesto post-pandemico, mirava al recupero delle liste d'attesa ambulatoriali e chirurgico-elettive.

La funzione di GO si incardina nell'organigramma aziendale con la Struttura Complessa Gestione Operativa che risponde direttamente al Direttore Generale. All'interno della S.C. Gestione Operativa insistono cinque aree tematiche, evolutesi progressivamente dal 2022 in poi:

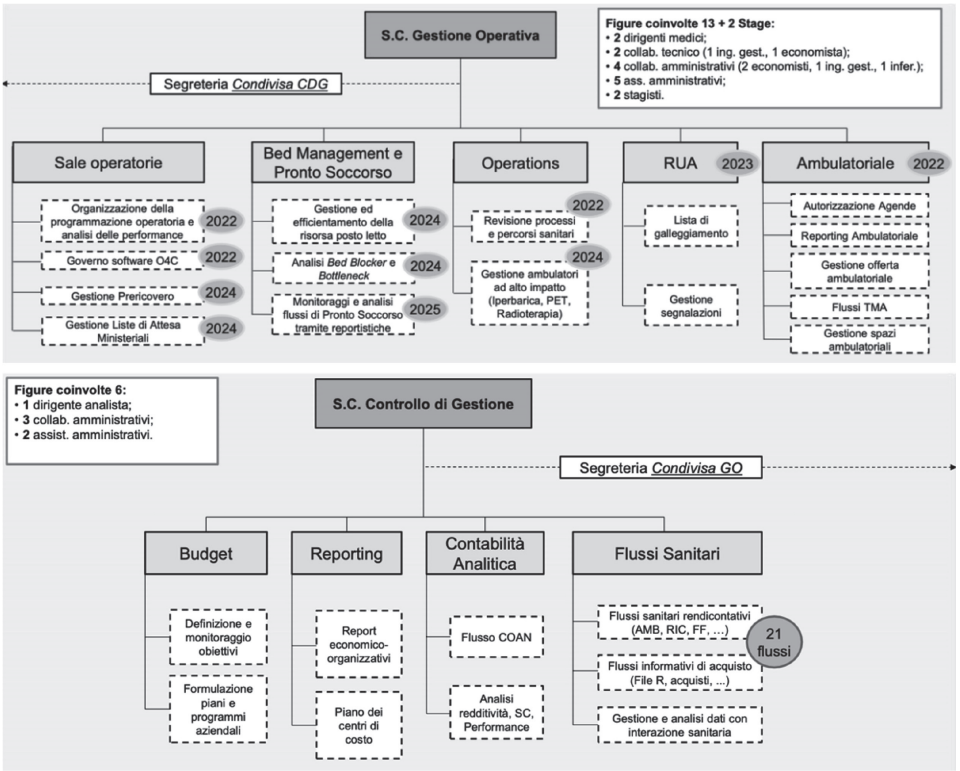
- S.S. Sale operatorie (2022): unità dedicata al governo del percorso chirurgico. È responsabile del funzionamento ottimale dei processi afferenti al Blocco Operatorio, della programmazione annuale/mensile/settimanale delle sedute, del monitoraggio degli scostamenti dalla programmazione e dell'individuazione di azioni correttive. Coordina i gruppi operativi di blocco (anestesista referente, coordinatore sanitario, chirurgo di specialità), funge da decisore ultimo per la gestione degli eventi contingenti nei diversi blocchi operatori ed è incaricata della supervisione delle iniziative di reingegnerizzazione e digitalizzazione del percorso chirurgico.
- Area Ambulatoriale (2022): ufficio deputato alla programmazione delle

agende, alla strutturazione di percorsi clinici outpatients, al reporting sulle performance ambulatoriali, alla definizione dell'offerta e alla razionalizzazione degli spazi dedicati alle attività ambulatoriali, sia ospedaliere che territoriali; effettua altresì, in collaborazione con altre Strutture aziendali, il monitoraggio e reporting in merito all'Attività Libero-Professionale Intramoenia (ALPI), in termini di volumi, tempistiche, prenotabilità e spazi.
- Ufficio RUA – Responsabile Unico Aziendale tempi di attesa (2023): presidia la c.d. lista di galleggiamento[4] e la gestione centralizzata delle segnalazioni relative ai tempi di attesa, operando come interfaccia fra cittadini, URP e unità operative e assicurando la conformità agli adempimenti ministeriali e il rispetto dei tempi di attesa.
- Area Bed Management e Pronto Soccorso (2024, 2025): articolazione in fase di sviluppo, che integra la gestione dei posti letto in elezione e in urgenza con il governo dei flussi di Pronto Soccorso, in linea con le recenti priorità regionali su boarding e riduzione delle degenze improprie.
- Area Operations (2022): area a funzione "incubatrice", cui vengono affidati progetti di reingegnerizzazione e sperimentazioni ad alto impatto.

Il team di GO è composto complessivamente da 15 professionisti ed è caratterizzato da una composizione multidisciplinare che include economisti, ingegneri gestionali, infermieri e medici. Questa eterogeneità di background riflette la natura trasversale e integrata delle funzioni assegnate alla struttura. Le competenze chiave richieste includono capacità di analisi dei dati, project management, conoscenze clinico-organizzative, padronanza degli strumenti informatici di supporto alla pianificazione e al monitoraggio (es. software di gestione sale operatorie), oltre a *soft skill* quali facilitazione dei processi decisionali, negoziazione interprofessionale e gestione del cambiamento. Il team lavora in stretta prossimità con le diverse linee produttive aziendali, ponendosi come punto di snodo tra il livello strategico e quello operativo per assicurare coerenza tra programmazione, attuazione e monitoraggio delle attività produttive. Le articolazioni identificate nella struttura GO operano in raccordo anche con figure e team esterni alla propria linea di responsabilità. Un esempio emblematico è rappresentato dall'area Bed Management, dove il dirigente medico afferente alla Gestione Operativa coordina non solo due risorse interne, ma anche sei infermieri gestiti gerarchicamente da altre strutture. Sebbene il CdG e la GO costituiscano due strutture organizzative distinte – entrambe configurate come Strutture Complesse – il loro funzionamento è caratterizzato da un'elevata interdipendenza (vedi Figura 18.2).

[4] Si tratta di liste d'attesa relative agli utenti che non riescono a essere prenotati entro i tempi massimi previsti e per i quali la stessa ASST si impegna a gestire la richiesta, attraverso la prenotazione presso l'Azienda o presso altri enti.

Figura 18.2 **Organigramma della SC GO e SC CG**



Fonte: Gestione Operativa ASST Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano.

Il CdG presidia le attività di budgeting, reporting economico-organizzativo, contabilità analitica e gestione dei flussi sanitari. Tuttavia, in virtù di una collaborazione e sinergia consolidata, fornisce supporto analitico e informativo alle progettualità sviluppate da GO. Laddove una specifica analisi si configuri come una necessità una tantum, è la GO stessa a costruire e trattare il dato. Quando invece l'analisi acquisisce stabilità e rilevanza strategica, essa viene trasferita sotto la responsabilità del CdG, diventando parte della reportistica routinaria. Altrettanto rilevanti sono le relazioni con la Direzione Medica di Presidio (DMPO) e con la Direzione delle Professioni Socio Sanitarie (DAPSS). Le tre funzioni operano, in molte occasioni, in stretta interazione per garantire il coordinamento tra la programmazione della capacità produttiva, la gestione clinica dei casi e l'organizzazione delle risorse professionali.

Ruolo, responsabilità e obiettivi della funzione

La funzione di GO esercita un ruolo di regia tecnico-organizzativa sui principali *asset* produttivi aziendali, con responsabilità che spaziano dalla program-

mazione operativa al coordinamento progettuale. In coerenza con gli indirizzi strategici aziendali e regionali, la GO collabora attivamente con le linee produttive ospedaliere e territoriali nella pianificazione dell'attività clinico-assistenziale, promuovendo l'efficienza dei percorsi, l'equità di accesso e la qualità dell'erogazione. Le responsabilità della funzione si articolano su più livelli. In primo luogo, è responsabile della programmazione e allocazione delle risorse produttive condivise, come sale operatorie, posti letto e ambulatori. Ciò include la distribuzione degli *slot* chirurgici, la definizione delle agende ambulatoriali in base ai vincoli di organico e di percorso, la pianificazione delle chiusure stagionali e la gestione delle logiche di saturazione delle diverse piattaforme assistenziali. A questi compiti si affianca la gestione temporanea di alcuni aspetti logistici, come l'assegnazione fisica degli spazi ambulatoriali. In secondo luogo, presidia l'analisi dei processi e il monitoraggio dei risultati. Supporta le unità operative nella gestione dinamica delle attività attraverso strumenti di analisi ad hoc e *dashboard* condivise.

Gli obiettivi della funzione, in parte proposti dal team di GO e in parte assegnati dalla Direzione Strategica o derivanti da vincoli regionali, vengono formalizzati nella scheda budget e condivisi con altre funzioni aziendali (es. Direzione Medica e DAPSS). Le aree di misurazione includono indicatori di produttività, saturazione e tempistiche di accesso, nonché progetti specifici come l'ottimizzazione del pre-ricovero o l'introduzione di nuovi standard (es. preparazione di materiali chirurgici secondo standard Joint Commission). Infine, la funzione svolge un ruolo chiave nel coordinamento di progetti di reingegnerizzazione, promuovendo interventi di miglioramento continuo in collaborazione con i professionisti clinici. I temi progettuali possono essere attivati su iniziativa della funzione, su input della Direzione Strategica o in risposta a priorità regionali. L'approccio è caratterizzato da una logica di sperimentazione, in cui le soluzioni sperimentate possono, in caso di successo, entrare nella routine organizzativa o essere trasferite ad altre funzioni (es. Controllo di Gestione).

Progettualità e risultati

Nel corso degli ultimi anni, la funzione GO ha promosso e implementato una serie di progettualità trasversali, volte a ottimizzare l'impiego delle risorse produttive aziendali e a migliorare l'efficienza dei percorsi di cura. Di seguito si riporta una sintesi delle principali progettualità:

- *Area chirurgica - sale operatorie.* Obiettivo prioritario dell'intervento è stato ottimizzare l'utilizzo delle sale operatorie, garantendo sostenibilità produttiva ed equità tra le strutture chirurgiche. Tra le azioni implementate vi sono: l'assegnazione degli slot operatori alle strutture cliniche, la definizione e il monitoraggio del *masterplan* mensile, l'analisi delle performance tramite

indicatori di saturazione e scostamento. Il sistema consente oggi la verifica mensile della sostenibilità produttiva, la riallocazione dinamica degli slot in base alle performance e il confronto diretto tra strutture.

- *Area chirurgica – revisione percorso chirurgico elettivo*. Il progetto si è focalizzato sull'efficientamento delle fasi pre-operatorie, al fine di garantire l'ingresso puntuale del primo paziente, di ridurre il rischio di cancellazioni e ottimizzare l'utilizzo delle risorse. A seguito di un'analisi dettagliata delle singole fasi (accettazione, visita anestesiologica, prelievo), è stato introdotto un nuovo processo di convocazione e sono stati definiti standard di ingresso per ciascuna fase. L'intervento ha portato a un'anticipazione media di 18 minuti dell'ingresso del primo paziente in sala e a una significativa riduzione dei tempi morti nella seduta operatoria.
- *Area chirurgica - percorso robotico*. È stato definito un blocco operatorio dedicato e introdotta la modalità delle "sedute lunghe", in grado di concentrare più interventi in una singola giornata. La funzione ha inoltre facilitato la condivisione della piattaforma tecnologica tra specialità chirurgiche diverse, attraverso un sistema di allocazione dinamica. Nel 2024 sono state programmate 1.050 sedute robotiche, con una *raw utilization* che oscilla dall'89% al 94%, risultati che collocano il percorso robotico tra quelli a più alta efficienza dell'ospedale.
- *Area Medica – Gestione Posti Letto*. L'intervento ha avuto l'obiettivo di razionalizzare l'utilizzo dei posti letto ospedalieri, integrando il monitoraggio dei flussi elettivi e urgenti e rafforzando il presidio sulle fasi di dimissione. La metodologia ha previsto il monitoraggio continuo della saturazione dei setting assistenziali e la programmazione dinamica delle chiusure/aperture stagionali in base alla domanda attesa. Il team di GO ha lavorato in stretta sinergia con i *bed manager* (infermieri) e con la Direzione Medica di Presidio, garantendo una maggiore prontezza nella gestione del boarding in Pronto Soccorso e una riduzione dei tempi di permanenza post-dimissione nei reparti, anche in collaborazione con la Centrale delle Dimissioni.
- *Area ambulatoriale*. Il progetto ha incluso una revisione delle agende in funzione delle risorse disponibili, la definizione di vincoli clinico-organizzativi (es. riservare slot per specifici percorsi) e l'introduzione di strumenti di reporting sulle performance. In stretta sinergia con il Controllo di Gestione, la funzione GO ha sostenuto un processo di contrattazione strutturato con i responsabili clinici, assicurando l'allineamento tra gli obiettivi di budget e la disponibilità effettiva di organico. L'intervento ha consentito di evitare aperture incoerenti rispetto alla capacità produttiva e ha migliorato la trasparenza nei confronti delle Direzioni strategiche e dell'utenza.

In termini generali, il contributo della funzione si è tradotto in un incremento significativo e misurabile della capacità produttiva aziendale e nel recupero

dell'attività post-covid a fronte di una sostanziale invarianza dell'organico. Infatti, in coerenza con gli obiettivi del PNGLA, l'ASST ha erogato oltre 60.000 prestazioni aggiuntive rispetto ai volumi del 2019, focalizzandosi su prime visite e diagnostica per immagini.

18.4.3 Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana è un presidio di II livello e un riferimento per l'alta complessità assistenziale, la didattica universitaria e la ricerca sanitaria. E' inserita all'interno dell'area vasta nord-ovest (LR n.40/2005) a cui riferisce una popolazione di oltre 1,2 milioni di abitanti. Dispone di circa 1.100 posti letto, oltre 5.000 dipendenti e un'ampia gamma di specialità mediche e chirurgiche (cardiochirurgia, neurochirurgia, oncologia, trapiantologia), con numerosi centri di riferimento regionali e nazionali.

La funzione GO nasce ufficialmente nel 2011, ma affonda le sue radici in un percorso avviato già dal 2010 all'interno della UOC Innovazione e Sviluppo e Analisi dei Processi in un contesto pubblico nazionale ancora scarsamente contaminato dalle logiche *operations*. In parallelo, la Regione Toscana inizia a promuovere in modo sistematico la diffusione della funzione di gestione operativa all'interno di un gruppo pilota di aziende sanitarie, anche attraverso progetti sperimentali e linee guida che rafforzano e validano il modello pisano (Del Vecchio e Roma, 2012). A partire dal 2014, la funzione si espande al governo dei posti letto, anche grazie allo sviluppo del progetto regionale "Net Visual DEA". L'obiettivo del progetto era quello di creare un network di aziende che operavano con logiche e strumenti propri della filosofia del Lean Thinking in particolare sui processi di emergenza-urgenza e sui flussi di ricovero da PS. Nel periodo 2016–2019 si struttura anche l'ambito ambulatoriale diventando promotrice del modello Open Access a livello regionale.

Configurazione organizzativa e organico

La funzione di Gestione Operativa dell'AOU di Pisa nasce come area funzionale trasversale in staff alla Direzione Sanitaria, storicamente coordinata dall'UO Innovazione e Sviluppo, anch'essa in staff alla Direzione Generale. Si tratta di una configurazione peculiare, pensata per garantire un baricentro operativo e, al tempo stesso, una forte integrazione decisionale, in particolare rispetto alla programmazione degli asset e dei volumi.

A partire dal 2020 sono state introdotte alcune modifiche significative agli assetti organizzativi, derivanti sia da revisioni interne sia da contingenze strutturali. Tali interventi hanno condotto a una progressiva separazione e a una maggiore autonomia decisionale tra gli ambiti inpatient e outpatient. Attualmente, la Gestione Operativa è sostanzialmente riconducibile alla funzione Innovazione e Sviluppo per l'area inpatient, e al Controllo di Gestione per l'area

outpatient. Oltre a una cooperazione reciproca, entrambe le articolazioni collaborano in modo integrato con la Direzione Sanitaria, la Direzione Medica di Presidio, il Dipartimento Infermieristico e il Dipartimento delle Professioni Tecnico-Sanitarie, nonché con un ampio numero di unità operative cliniche e amministrative, secondo una logica trasversale.

Il team di GO dell'area inpatient è composto da un nucleo tecnico di 6 professionisti, di cui 2 a tempo pieno, con background eterogenei: ingegneri, economisti, infermieri, e figure tecniche con formazione manageriale. Al team si aggiunge il Visual manager aziendale e i 4 professionisti dell'articolazione del Visual Hospital inserita nella UO Innovazione e Sviluppo. Per ciascuna delle aree su cui opera la gestione operativa inpatient è presente un referente sanitario della direzione medica di presidio ovvero un medico igienista. A questa organizzazione si aggiunge una rete estesa di referenti clinici e sanitari nei reparti (unità di programmazione). Il team outpatient è costituito da 4 unità sanitarie e 3 amministrative dedicate alla programmazione delle attività e alla strutturazione delle agende CUP. Due ingegneri gestionali completano il presidio tecnico, condividendo parte del loro tempo con il controllo di gestione.

Ruolo, responsabilità e obiettivi della funzione

Sia la funzione che presidia l'area *inpatient* che quella che presidia l'*outpatient* sono orientate all'ottimizzazione degli asset produttivi dei Dipartimenti e delle Unità Operative, in coerenza con le linee strategiche e programmatiche definite dalla Direzione Aziendale anche attraverso il processo di budget. La responsabilità diretta delle risorse resta in capo ai Direttori di DAI e UO, supportati da figure di coordinamento che assicurano coerenza operativa e organizzativa tra le strutture.

Le funzioni presidiano la pianificazione e la gestione quotidiana degli asset produttivi, sia per la linea *inpatient* sia per quella *outpatient*, adattando l'offerta ai trend della domanda. Attraverso dashboard e strumenti digitali in tempo reale, visualizza gli *asset*, monitora la produzione, individua tempestivamente criticità e garantisce l'equilibrio tra domanda e offerta.

Elemento distintivo è la gestione diretta e autonoma di risorse incentivanti dedicate alla flessibilità produttiva e alla rimodulazione dell'attività in funzione dei bisogni contingenti e degli obiettivi aziendali – ad esempio per incrementare la produzione in specifici setting o fronteggiare carenze improvvise di personale. Ciò consente un governo rapido dei volumi produttivi. La Gestione Operativa è inoltre motore di innovazione organizzativa, come approfondito di seguito.

Progettualità e risultati raggiunti

Tra le principali progettualità implementate nell'area *inpatient* si segnalano:

- *Area chirurgica.* L'introduzione del Master Schedule Plan ha permesso una pianificazione centralizzata delle sale operatorie, migliorando il coordinamento del percorso chirurgico. L'introduzione di strumenti per il governo delle dimissioni anche e soprattutto in area critica ha portato a una riduzione dei rinvii intempestivi degli interventi chirurgici per mancanza di disponibilità in area critica dal 60% al 4% e a un sensibile incremento nella saturazione e nell'efficienza di utilizzo delle sale. In merito alla gestione dei tempi di attesa per patologia oncologica ad agosto 2025 AOUP registra il rispetto dei 30 gg nel 91,4 %dei casi.
- *Visual Hospital e governo dei posti letto.* L'implementazione della centrale operativa Visual Hospital ha consentito un governo real-time dei flussi di ricovero, supportando l'equilibrio tra emergenza-urgenza e ricoveri programmati. L'introduzione di strumenti di pianificazione dei posti letto e del percorso di ricovero del paziente hanno prodotto un maggior turn over degli stessi e una riduzione della degenza media nei percorsi di emergenza-urgenza in particolare in area medica (nel primo anno di implementazione del progetto è stato raggiunto il risultato di 6 gg di degenza media in area medica);

Di seguito si riportano le principali progettualità in ambito *outpatient*:

- *Estensione del modello di Open Access Ambulatoriale.* Introdotto nel 2015 nell'area cardiologica e, dal 2020, progressivamente esteso a tutte le visite specialistiche monitorate dal PNGLA (esclusa la diagnostica), il modello prevede l'apertura giornaliera e progressiva delle agende per garantire la prima visita entro tre giorni. L'iniziativa ha coinvolto oltre 300 agende, consentendo di riallineare domanda e offerta, ridurre drasticamente i tempi di attesa (da mesi a pochi giorni in molte specialità) e assicurare il rispetto stabile degli standard regionali di accesso alle cure. La percentuale di visite erogate entro i tempi standard è passata dall'88,3% nel 2019 al 97,7% nel 2025.
- *Efficientamento della diagnostica per immagini.* Attraverso interventi di ottimizzazione organizzativa e tecnologica, la produzione complessiva semestrale di prestazioni radiologiche è aumentata dell'11%, passando da 184.931 esami nel 2019 a 206.681 nel 2025.
- *Incremento della saturazione delle agende ambulatoriali.* L'indice di utilizzo delle agende è cresciuto dal 54,9% di gennaio 2023 al 62,6% di giugno 2025, segnalando un uso più efficiente e continuativo delle risorse disponibili.
- *Riorganizzazione dei punti di accesso e dei front office.* L'Azienda ha avviato un processo di revisione dei percorsi di accesso, con l'accentramento degli sportelli di accettazione e l'introduzione di soluzioni digitali per la gestione autonoma da parte dell'utenza. Sono stati installati totem di self-accettazio-

ne che consentono di snellire i flussi, ridurre le attese e migliorare l'esperienza del paziente.

- *Mapping spazio–attività e progettazione ospedaliera.* L'utilizzo di strumenti avanzati di mapping ha consentito di riallineare domanda e offerta di spazi clinici e ambulatoriali, risultando fondamentale anche nella progettazione del nuovo ospedale. Quest'ultimo prevede una riduzione da circa 650 a 470 stanze ambulatoriali, con un impiego condiviso, flessibile e dinamico delle aree disponibili.

18.4.4 Azienda Ospedaliera Universitaria di Alessandria

L'Azienda Ospedaliera Universitaria "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria (AOU AL) comprende tre presidi principali, un poliambulatorio centrale, sedi amministrative e la Centrale Operativa 118. Con 695 posti letto attivi (di cui 90 in Day Hospital), è riconosciuta come DEA di II livello e rappresenta l'hub ospedaliero di riferimento per l'area Piemonte Sud-Est. L'organico supera le 2.500 unità: circa 400 medici, oltre 1.400 infermieri, tecnici, ostetriche e riabilitatori, e circa 700 addetti tecnico-amministrativi e di supporto.

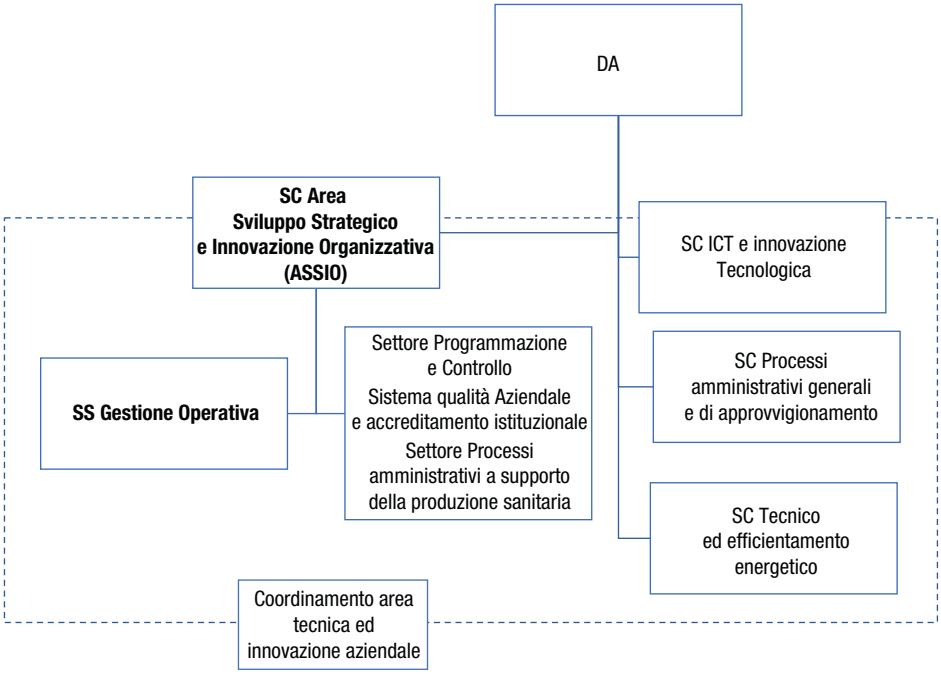
Le prime esperienze di gestione operativa risalgono al 2009, nell'ambito della funzione Qualità, attraverso attività di audit e progetti di governo clinico e sviluppo di PDTA. Nel quinquennio successivo, l'integrazione sotto un unico responsabile delle aree Qualità e Controllo di Gestione favorisce la nascita di una visione unitaria, orientata alla razionalità operativa. Questo percorso porta, nel 2019, alla creazione della Struttura Complessa Area Sviluppo Strategico e Innovazione Organizzativa (ASSIO), che riunisce tre settori — Qualità e Accreditamento, Controllo di Gestione e Processi Amministrativi — all'interno della quale la Gestione Operativa viene formalmente riconosciuta: inizialmente come attività della referente e, dal 2021, come struttura semplice dedicata.

Configurazione organizzativa e organico

La funzione di Gestione Operativa è composta da tre professionisti con background ingegneristico ed economico, ciascuno dedicato a una specifica area produttiva (medica, chirurgica, ambulatoriale). Inserita nella SC ASSIO, in staff alla Direzione Amministrativa, la funzione opera in un contesto fortemente integrato con le altre tecnostrutture aziendali.

ASSIO riunisce oltre 70 dipendenti e unifica sotto un'unica regia le principali funzioni di supporto. Sei risorse sono distribuite tra i settori Controllo di Gestione e Qualità, mentre circa 60 operano nei Processi Amministrativi, che includono il CUP Governo (gestione delle agende ambulatoriali) e il coordinamento di AURA (Accesso Unico Ricovero e Ambulatoriale). La funzione di GO collabora quotidianamente con queste strutture, condividendo strumenti, dati e processi di analisi.

Figura 18.3 **Posizionamento della SS Gestione Operativa negli assetti organizzativi**



Fonte: rielaborazione a cura degli autori sulla base dell'organigramma originale

Ruolo, responsabilità e obiettivi

La Gestione Operativa svolge un ruolo di supporto tecnico e di coordinamento nella programmazione e nell'allocazione degli asset produttivi, partecipando attivamente ai tavoli decisionali aziendali.

In ambito chirurgico fa parte del gruppo di programmazione aziendale, che comprende la Direzione Medica di Presidio, la Direzione delle Professioni Sanitarie, il Responsabile Unico Aziendale (identificato nel Direttore di ASSIO), la funzione GO e il facilitatore dei blocchi operatori. Il gruppo definisce le strategie operative e propone azioni di miglioramento, intervenendo sulla programmazione tattica e settimanale. Ogni giovedì si riunisce con i dipartimenti chirurgici per validare e aggiornare le liste operatorie della settimana successiva. La GO coordina e supporta questi momenti fornendo analisi, proposte e verifiche di coerenza con i criteri regionali e aziendali.

A livello strategico, la funzione contribuisce indirettamente, tramite il Direttore di ASSIO (e RUA), al gruppo incaricato della definizione del Master Surgical Schedule, che comprende la Direzione Strategica, il Direttore Medico dei Presidi, il Direttore Infermieristico e i Direttori dei Dipartimenti Chirurgi-

ci. La gestione quotidiana del blocco resta invece in capo al gruppo operativo, formato da figure mediche e infermieristiche dedicate.

Gli obiettivi della funzione sono definiti dal Direttore di ASSIO in accordo con la Direzione Amministrativa e formalizzati nelle schede di budget. Riguardano il supporto al miglioramento della produttività, dell'accessibilità, dei livelli di saturazione delle risorse e della qualità percepita dagli utenti. Questo sistema di responsabilizzazione consente di operare secondo logiche di governo per risultati. Molti obiettivi sono condivisi con i settori Flussi, Controllo di Gestione e Qualità di ASSIO e declinati anche a livello di Strutture Complesse e Semplici Dipartimentali, in coerenza con le logiche di efficientamento e soddisfazione dell'utenza.

Progettualità e risultati raggiunti

Di seguito si sintetizzano le principali iniziative portate avanti dalla funzione di GO, in stretta collaborazione con gli altri settori di ASSIO sotto la direzione di ASSIO:

- *Area medica ed emergenza.* L'intervento ha riguardato l'efficientamento dei percorsi di ricovero, in particolare dell'area medica e dal Pronto Soccorso, per ridurre il sovraffollamento e migliorare la rotazione dei posti letto in logica pull. Sono stati introdotti: un cruscotto di monitoraggio in tempo reale dei posti letto e un gemello virtuale del Pronto Soccorso per simulare le azioni di miglioramento. Le misure principali hanno riguardato la pianificazione dei posti letto riservati ai pazienti in attesa di ricovero, la definizione di un ritmo di dimissioni più coerente con gli accessi e l'attivazione di un ambulatorio diurno per i codici azzurri, casi di media intensità ma ad alto impatto gestionale. Complessivamente, le iniziative hanno ridotto in modo significativo il tasso di sovraffollamento.
- *Area chirurgica.* È stata riorganizzata la gestione del blocco operatorio con l'adozione di un modello di governance su tre livelli e cruscotti interattivi per il monitoraggio settimanale. L'introduzione di criteri standard per la composizione delle sedute ha consentito di aumentare gli interventi complessi a parità di risorse, dimezzare l'indicatore score (priorità e tempi d'attesa), regolarizzare circa 700 posizioni di lista e ridurre del 20% i pre-ricoveri scaduti.
- *Area front office.* È stato creato un unico punto di accettazione per ricoveri e prestazioni ambulatoriali, con sistemi automatizzati di accoglienza tramite totem e postazioni self-service. Il nuovo modello ha migliorato la coerenza tra domanda e offerta, ridotto la frammentazione dei percorsi e aumentato la tracciabilità dei flussi.
- *Area ambulatoriale.* In coerenza con il PNGLA, la funzione OM ha operato sul governo delle agende, sull'integrazione tra attività istituzionale e libera professione e sulla verifica della compatibilità tra volumi e risorse. Gli stru-

menti introdotti hanno permesso di intervenire in modo proattivo su colli di bottiglia e criticità, migliorando l'allineamento agli standard regionali.

- *Supply chain dei dispositivi medici.* È stato avviato un percorso di miglioramento della micro-logistica dei dispositivi medici gestiti a stock, a transito e in conto deposito, basato su metodologie lean (classificazione ABC e mappatura dei processi).

18.5 Analisi congiunta di casi e interviste agli esperti: gli idealtipi di funzioni di OM

L'analisi congiunta dei quattro casi studio e delle interviste agli esperti restituisce un quadro coerente della fase attuale di sviluppo delle funzioni di OM nel sistema sanitario italiano. Rispetto alla stagione pionieristica documentata nei precedenti Rapporti OASI, le esperienze analizzate mostrano funzioni oggi più strutturate, riconosciute e radicate nei processi decisionali, pur con differenze significative nelle traiettorie di evoluzione, negli assetti organizzativi e nei ruoli effettivamente assunti.

18.5.1 Mission e oggetti di lavoro

Sia dall'analisi dei casi aziendali che dalle interviste agli esperti viene confermato quanto emerso nei rapporti precedenti: le funzioni nascono dall'esigenza di orientare le aziende verso l'ottimizzazione dei flussi e degli asset e rafforzare il governo della produzione attraverso il presidio della programmazione. In generale, l'area chirurgica costituisce quasi sempre il focus iniziale, essendo un ambito ad alta intensità tecnologica, elevata standardizzazione e rilevante impatto economico. Man mano che la funzione si consolida, a prescindere dal ruolo assunto in azienda, il raggio di azione si estende alle aree mediche, con particolare attenzione alla gestione dei posti letto e alla riduzione del boarding nei pronto soccorso, e infine alle attività ambulatoriali, dove il presidio delle agende rappresenta una leva cruciale per migliorare l'accessibilità e la produttività complessiva.

18.5.2 Ruoli, configurazioni organizzative e organico: 5 idealtipi

Il capitolo si concentra ora su un ambito ancora poco approfondito e confuso e cioè quello dei ruoli e dei modelli organizzativi. Le evidenze raccolte nei quattro casi delineano una funzione in consolidamento, che ha progressivamente superato la dimensione sperimentale per avvicinarsi a una configurazione stabile di governo operativo, anche se con tratti ancora fluidi e differenziati.

Per quanto riguarda gli assetti organizzativi, le funzioni di OM nei quattro

casi appaiono molto eterogenee. Humanitas ha sviluppato una vera e propria Direzione Operativa autonoma incardinata "in line" sotto la Direzione Generale. Nelle tre aziende pubbliche le funzioni sono formalmente in staff alla direzione strategica, ma bisogna notare come abbiano referenti diversi. Niguarda ha istituito una Struttura Complessa, in staff al Direttore Generale. A Pisa la funzione è oggi divisa tra la Direzione UO innovazione e sviluppo (inpatient) e la UO del Controllo di Gestione (outpatient), riflettendo evoluzioni recenti e ancora non pienamente consolidate. Alessandria, infine, colloca la GO all'interno della SC ASSIO, in staff alla Direzione Amministrativa, che unisce controllo di gestione, qualità e processi amministrativi.

Dal punto di vista degli organici Humanitas e Niguarda dispongono di team consistenti (intorno alla dozzina di professionisti), caratterizzati da un forte orientamento multidisciplinare: ingegneri gestionali, economisti, medici, infermieri e figure con background umanistico e manageriale. Pisa conta 12 professionisti nell'area inpatient e un team più ridotto in area outpatient, integrato con il Controllo di Gestione; complessivamente, si osserva un mix tra profili tecnici e clinici. Alessandria, invece, ha un nucleo GO molto contenuto (tre professionisti), ma opera all'interno di un ecosistema più ampio (SC ASSIO) che garantisce accesso a competenze aggiuntive in ambito qualità, controllo di gestione e processi amministrativi. Pur con differenze di assetto e organico, in tutti i casi la funzione di OM non è più mero esecutore di obiettivi top-down, ma si configura, con diverse gradazioni e intensità, come promotore di innovazione organizzativa e un regista della programmazione degli asset e dei flussi.

L'analisi delle interviste agli esperti ha permesso poi di espandere lo spettro della casistica e di intercettare anche quelle realtà in cui la funzione è presente formalmente, ma con un ruolo di analista e project manager nei processi di innovazione. Ecco, dunque, che dall'analisi congiunta di casi ed esperti emergono diverse interpretazioni del ruolo che la funzione di OM può assumere nelle aziende sanitarie. Queste configurazioni rappresentano altrettante modalità con cui l'Operations Management viene interpretato e tradotto in pratica, a seconda della storia, della maturità organizzativa e delle condizioni di contesto. Nel modello interpretativo proposto, la posizione di ciascuna funzione può essere letta lungo due dimensioni fondamentali, che congiuntamente definiscono la natura e la profondità del ruolo assunto.

La prima riguarda il bilanciamento tra gestione della routine e disegno dell'innovazione. Alcune funzioni operano prevalentemente sulla dimensione della continuità produttiva, garantendo la regolarità dei flussi, la saturazione degli asset e la sostenibilità economica delle attività. In questo caso, la funzione di OM si configura come un presidio di efficienza e stabilità organizzativa.

La seconda dimensione distingue la postura del consulente da quella dell'owner degli asset. Nelle prime due interpretazioni, il consulente tecnico e

il consulente strategico, la funzione agisce in una logica di supporto. Si tratta di strutture leggere, spesso collocate in staff, che offrono analisi, metodologie e strumenti per l'innovazione dei processi. Il loro impatto è indiretto, ma possono avere un ampio raggio d'azione progettuale. Lavorando a progetto, queste funzioni sviluppano conoscenze e strumenti trasversali, ma rischiano di perdere continuità nel tempo e di non incidere in modo stabile sulla gestione ordinaria.

Nell'interpretazione del regista alto, la funzione di OM esercita un ruolo di coordinamento funzionale, collocandosi tra la direzione strategica e le unità operative. Non è titolare diretta degli asset, ma partecipa ai processi decisionali, negozia obiettivi e contribuisce alla definizione delle politiche produttive.

Con le interpretazioni del direttore del processo e della centrale operativa, la funzione assume un livello di responsabilità più profondo. In queste configurazioni, la OM diventa un vero e proprio owner del processo, con autonomia gestionale e potere decisionale. Nel momento in cui una funzione di OM assume il ruolo di centrale operativa di fatto gestisce direttamente porzioni di processo e di risorse (umane e asset), intervenendo in tempo reale sui flussi.

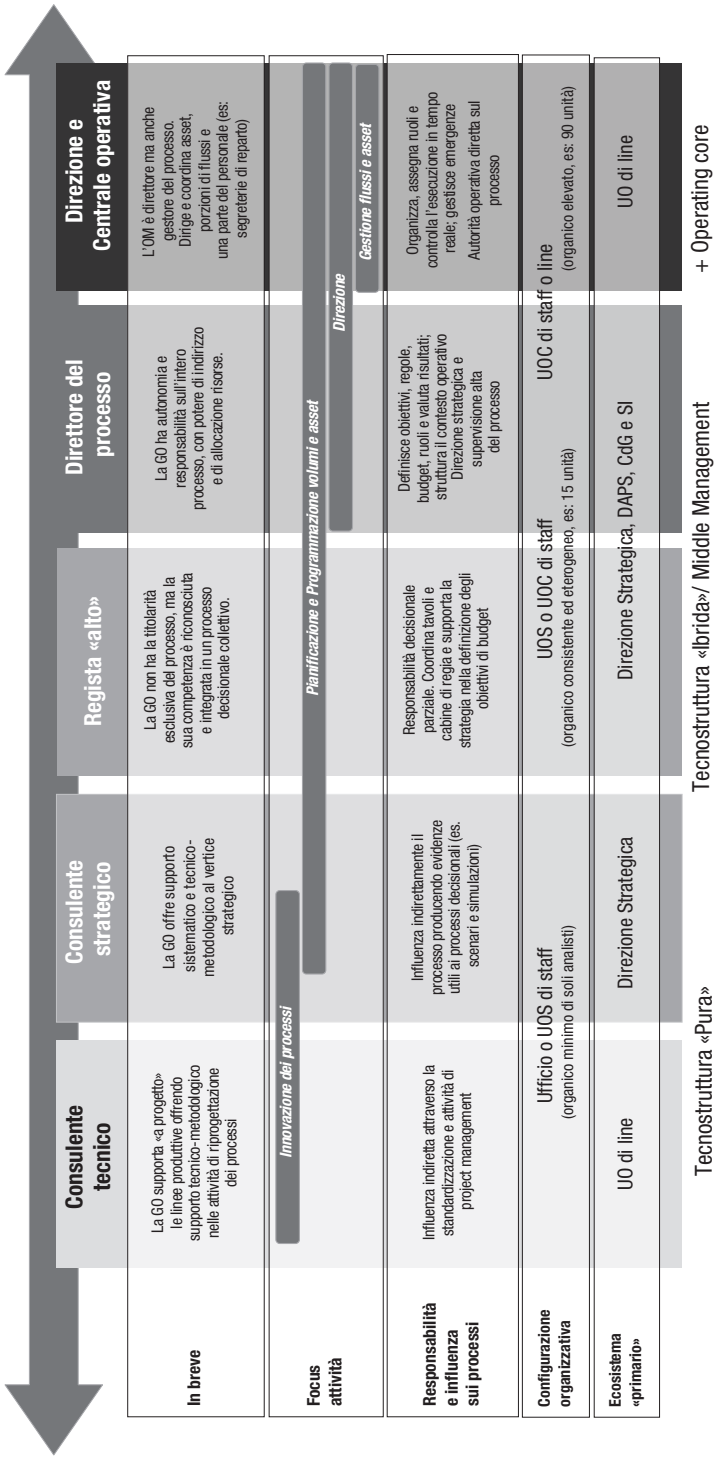
Le dinamiche dell'organico non seguono i modelli in modo progressivo in quanto ciascun idealtipo, se consolidato, può portare ad avere organici variabili dalla 5 alle 12 unità a seconda del numero dei focus della funzione (inpatient, outpatient, ecc.). Il "salto" più netto avviene di fatto tra i primi e l'ultimo a cui vengono assegnate risorse di line.

Questi cinque idealtipi rappresentano, in prospettiva, un quadro evolutivo dell'Operations Management in sanità, che va letto non come successione lineare di fasi, ma come un insieme di posture che coesistono e si ridefiniscono in base al contesto organizzativo e al mandato gestionale. Sulla base di questa proposta di *framework* interpretativo, la AOU di Alessandria si collocherebbe in un intorno tra il consulente strategico e il regista alto, le funzioni del Niguarda e di Pisa più centrate sul regista alto e Humanitas sul direttore di processo.

Dalle interviste emergono due rischi da tener presente: l'espansione del perimetro operativo non è sempre accompagnata in modo adeguato dall'organico o dalle competenze necessarie. In questo secondo caso ci si riferisce a situazioni in cui la struttura arriva ad includere ambiti non propriamente operations, quali la libera professione o il rischio clinico.

Rispetto al secondo asse secondo gli esperti, è indubbio che la funzione per esprimersi al meglio debba essere almeno "regista" e possa dare il suo contributo per orientare i processi produttivi. Nei primi due casi il rischio è che gli sforzi di una revisione dei processi in chiave OM sia frammentata, sporadica e non trovi continuità. C'è invece meno chiarezza rispetto a come la funzione possa essere incisiva sui processi di programmazione o gestione. Una OM che assume una postura da "centrale operativa" gestisce gli snodi fondamentali dei processi in prima persona ed ha la possibilità di intervenire direttamente "in

Figura 18.4 **I cinque idealtipi di funzioni dell'Operations Management**



corso d'opera". Da un lato, gli intervistati che hanno sperimentato questa fattispecie indicano che possono agilmente incidere sul processo e fare gestione operativa. Dall'altra parte, temono che questo possa portare a una de-focalizzazione in quanto si inserisce un'attività di gestione del personale (turnistica, valorizzazione, ecc.) che sovraccarica la funzione e appesantisce la funzione. Riprendendo i casi, sia Humanitas che Alessandria hanno avuto delle fasi di "espulsione" di alcune componenti (rispettivamente Customer service e Ufficio Tecnico) per rimanere sufficientemente snelle.

Il tema dell'organico si lega in ogni caso anche alla dimensione aziendale per cui è possibile avere OM registe anche con organici relativamente contenuti in aziende medio-piccole. Al tema della quantità si deve poi associare quella del mix di competenze. Le configurazioni osservate attraverso l'esperienza dei professionisti, specialmente quelle più mature, includono sia profili tecnici e gestionali, sia figure con esperienza clinica, come gli infermieri di processo. Da un lato emerge la necessità di avere una componente analitica e sistemica della funzione, dall'altro si sottolinea l'importanza della conoscenza operativa e delle capacità relazionali nel dialogo con i reparti. Nel riconoscere il carattere ibrido della OM, gli esperti restano quindi aperti sulla leadership professionale nonostante le loro chiare matrici disciplinari di partenza.

18.5.3 Obiettivi di risultato e cassetta degli attrezzi

Gli obiettivi e la cassetta degli attrezzi sono quelli classici dell'Operations Management e del Lean Management. Dall'analisi dei casi emergono tuttavia alcune specificità nella loro applicazione in sanità e nella definizione delle priorità operative. Oltre agli obiettivi legati ai volumi produttivi, alla saturazione degli *asset* e alla tempestività dei processi, si stanno consolidando anche quelli relativi alla qualità percepita e alla *patient experience*.

Un elemento trasversale a tutte le esperienze riguarda la complessità nel disporre di metriche solide e omogenee. La disponibilità di dati affidabili e confrontabili è spesso limitata da sistemi informativi frammentati, da processi di raccolta non standardizzati e da resistenze organizzative nell'uso dei dati a fini gestionali. In molti casi, la costruzione dei cruscotti e degli indicatori di performance è frutto di un lavoro interno della funzione stessa, che deve integrare fonti eterogenee e spesso non interoperabili. Tale attività, che richiede competenze analitiche avanzate e una stretta collaborazione con i Sistemi Informativi, rappresenta una delle sfide più rilevanti per la maturazione della funzione di OM.

Nonostante tali difficoltà, i risultati raggiunti nei progetti analizzati confermano la capacità della OM di generare impatti misurabili. Humanitas ha registrato un incremento della saturazione delle agende ambulatoriali fino al 100% in alcune aree e una riduzione dei ricoveri inappropriati; Niguarda ha migliora-

to l'efficienza del percorso chirurgico con un'anticipazione media di 18 minuti dell'ingresso del primo paziente in sala e una raw utilization delle sale robotiche superiore all'89%; Pisa ha ridotto la degenza media in area medica a 6 giorni e garantito il rispetto dei tempi di attesa oncologici nel 91,4 % dei casi; Alessandria ha dimezzato i tempi di attesa operatori e ridotto del 20 % i pre-ricoveri scaduti. Questi risultati, pur con eterogeneità di contesto e strumenti, mostrano come la presenza di una funzione di OM strutturata possa tradursi in miglioramenti tangibili in termini di efficienza, accessibilità e qualità del servizio. Il monitoraggio continuo delle performance – tramite dashboard e sistemi di visual management – si conferma quindi non solo come leva tecnica, ma come meccanismo di apprendimento organizzativo e di legittimazione della funzione stessa.

18.6 La lenta diffusione e consolidamento delle funzioni di Operations Management: driver di sviluppo e sfide future

18.6.1 L'importanza dell'ambiente di riferimento: fattori facilitanti e ostacolanti

Nella progettazione delle funzioni di OM emerge come fondamentale il tema della strutturazione delle interazioni con gli attori del suo "ambiente primario" e di come la configurazione organizzativa possa aiutare o meno a valorizzarle. Si tratta in particolare delle tecnostrutture adiacenti, della direzione strategica e naturalmente dalla line.

Rispetto alla line, la funzione di OM continua a misurarsi con resistenze culturali interne, in particolare da parte del personale clinico, che spesso interpreta l'ingresso della componente gestionale nei percorsi assistenziali come una minaccia all'autonomia professionale. In assenza di potere decisionale sul processo, la costruzione di fiducia, la continuità relazionale e la dimostrazione di utilità operativa sono fattori chiave per superare questo ostacolo, ma non sempre riescono a consolidarsi nel breve periodo. Dove invece la funzione è riuscita a essere percepita come leva di facilitazione — e non di controllo — essa ha potuto accreditarsi come interlocutore stabile.

Un altro aspetto chiave è poi lo sviluppo di una interazione efficace con il Controllo di Gestione (CdG) e i Sistemi Informativi. In alcune esperienze, OM e CdG operano come strutture parallele e distinte, ma integrate attraverso un coordinamento operativo continuo, che consente alla funzione di OM di alimentare il CdG con dati analitici o di riceverne supporto su progettualità strategiche (es: Niguarda e Humanitas). In altri casi, le due funzioni risultano più strettamente connesse, fino a essere co-localizzate all'interno della stessa unità organizzativa (es: AOU Alessandria) o, addirittura, a includersi (Es: AOU Pisa per la parte outpatient, ma anche San Gerardo di Monza, Policlinico di Mila-

no). Le opinioni espresse variano: alcuni professionisti sottolineano l'efficacia di una separazione funzionale, che salvaguarda il focus operativo della OM; altri riconoscono il valore di una sinergia stretta, utile per coniugare capacità trasformativa e sostenibilità economica. In ogni caso, il CdG si configura come interlocutore privilegiato della OM, sia per l'allineamento strategico che per la costruzione di un linguaggio comune fondato su evidenze. L'equilibrio tra prossimità e autonomia risulta pertanto una variabile cruciale nella definizione degli assetti più efficaci. Per operare la OM ha bisogno di evidenze solide su tempi di processo e saturazione degli asset che spesso non sono nei radar dell'organizzazione. Per poter agire sulla programmazione con evidenze "incontrovertibili" che scardinino le resistenze dei professionisti e monitorare in tempo reale l'andamento della "produzione" e l'assorbimento degli asset, i SI diventano uno snodo cruciale e alcuni referenti segnalano come una sovra-ordinazione gerarchica consenta di plasmare più facilmente la logistica delle informazioni, dai sistemi di rilevazione dei dati (data entry) ai sistemi di reporting.

Vi è poi tutta la questione della relazione con gli apicali. Non vi è concordanza su quale sia il referente "ideale" (DG, DS o DA), ma tutti concordano sull'importanza del commitment della direzione strategica sia in fase di "start-up" che in fase di sviluppo e crescita. Proprio perché la OM può assumere un ruolo sempre più determinante nelle scelte di produzione possono intervenire dinamiche viziose tra strategia e OM che, aggiunta alle forze dal basso, ne frenano lo sviluppo. Emerge quindi come elemento chiave non solo il commitment della strategia ma anche la capacità di indirizzare la OM con una visione strategica, così come la capacità della OM di intercettare e riconoscere la strategia.

A livello di cultura organizzativa e non tanto organizzativo, emerge un ultimo spunto. La dimensione del "potere" sulle piattaforme spiega probabilmente le maggiori difficoltà delle aziende pubbliche a sviluppare l'OM rispetto a quelle private accreditate, nelle quali è più diffusa l'idea che i fattori produttivi siano dell'Azienda e non dei professionisti. La rinuncia al controllo sui fattori produttivi da parte dei professionisti è compensata dalle possibilità offerte dall'azienda stessa in termini di volumi e casistica. Si tratta in questo caso di una prima indicazione fornita dall'analisi dei casi che andrà approfondita con ulteriori indagini.

Uscendo fuori dall'ambiente interno, è interessante notare come il ruolo della regione nello sviluppo della funzione sia oggetto di valutazioni differenziate. In alcuni casi è percepito come un vincolo, per via di modelli organizzativi e strumenti standardizzati poco aderenti alle esigenze operative delle aziende. In altri, l'intervento regionale è stato invece interpretato come un fattore abilitante, capace di sostenere la strutturazione della funzione OM attraverso la diffusione di strumenti comuni e riferimenti condivisi. Le posizioni oscillano tra la richiesta di un maggiore riconoscimento formale della funzione a livello di sistema e la difesa di spazi di adattamento locale.

18.6.2 Le sfide future

Riprendendo la disamina dell'ambiente e delle possibili resistenze allo sviluppo della funzione di OM, la costruzione di alleanze organizzative e culturali all'interno delle rispettive organizzazioni rimane una delle sfide tipiche di queste funzioni. Dalle interviste agli esperti e dai casi aziendali emerge come la legittimazione della funzione non deriva tanto da meccanismi gerarchici quanto dalla capacità di essere percepita come leva di facilitazione. La funzione di OM efficace è quella che coniuga rigore analitico e intelligenza relazionale, trasformando il dato in strumento di dialogo e co-decisione. L'autorevolezza della funzione si costruisce nel tempo, attraverso la capacità di risolvere problemi concreti, promuovere processi di confronto e favorire la corresponsabilità dei risultati.

A questo si lega anche una sfida di sistema. Pur riconosciuta da alcune regioni, la funzione non dispone ancora di un profilo codificato, di percorsi di carriera dedicati e di meccanismi di sviluppo delle competenze che ne assicurino la continuità. La conseguenza è una dipendenza strutturale dalle figure fondatrici e dalle specifiche culture aziendali. Secondo gli esperti, solo la definizione di un quadro professionale condiviso e l'attivazione di percorsi di formazione specifica potranno garantire stabilità e diffusione sistemica.

Vi è poi la questione della trasformazione digitale e l'uso del dato come leva di governo. e da un lato la OM è ormai il principale produttore di dati operativi, dall'altro ne rimane un utilizzatore parziale. La frammentazione dei sistemi informativi, la scarsa interoperabilità e la non ancora completa digitalizzazione riducono la capacità di lettura integrata dei processi. Tuttavia, la digitalizzazione non è vista solo come un obiettivo tecnologico, ma come un cambio di paradigma gestionale: la OM deve evolvere da funzione che "misura" a funzione che "interpreta", assumendo un ruolo di regia nella traduzione dei dati in decisioni operative e nella progettazione di modelli predittivi.

Un altro fronte riguarda l'estensione del perimetro operativo verso i nuovi setting territoriali. Gli esperti concordano sul fatto che, di fronte alla riorganizzazione dell'assistenza prevista dal DM 77 e dal PNRR, le competenze di operations management debbano essere trasferite anche nei contesti di prossimità, dove la frammentazione dei flussi e la scarsità di strumenti gestionali ripropongono le sfide già affrontate in ambito ospedaliero. In questo scenario, la OM può diventare il motore di una continuità organizzativa tra ospedale e territorio, capace di garantire coerenza e integrazione tra i diversi nodi della rete assistenziale. Dalle interviste emerge poi la necessità di sviluppare una cultura organizzativa capace di tradurre le logiche operative in valore percepito per il paziente, secondo un approccio concretamente *value based*.

Guardando al futuro, le frontiere più avanzate sono rappresentate dalla medicina predittiva e dall'intelligenza artificiale: la prima perché cambierà radi-

calmente la logica della programmazione, spostando l'attenzione dal volume al bisogno potenziale; la seconda perché potrà automatizzare parte delle attività di analisi e di pianificazione, liberando risorse per la gestione di processi complessi e per l'innovazione organizzativa.

Nel loro insieme, i casi aziendali e le riflessioni dei professionisti convergono nel rappresentare una funzione che ha ormai superato la fase sperimentale e che, pur tra tensioni e asimmetrie, si configura come leva strategica per il governo delle operations sanitarie. La funzione di OM emerge come spazio di connessione tra direzione, clinica e sistemi informativi: una funzione ibrida, in cui la competenza analitica, la capacità relazionale e la legittimazione strategica costituiscono le chiavi per garantire sostenibilità, efficienza e valore per il paziente.

18.7 Conclusioni

Guardando la situazione come ci viene ora consegnata dai casi aziendali, sia per via diretta, sia per via indiretta, attraverso il racconto dei protagonisti, appare evidente come alcune attese diffuse nel decennio precedente, di una più robusta e definita strutturazione organizzativa della funzione, non abbiano trovato realizzazione. Infatti, rispetto alla diffusione di logiche e strumenti di OM nelle aziende, le esperienze di strutturazione della funzione rimangono complessivamente limitate e visibilmente eterogenee.

Implicita nell'osservazione, citata all'inizio del capitolo, che fosse allora (2012) prematuro pensare agli assetti organizzativi, era l'idea che a un consolidamento di saperi e strumenti avrebbe fatto seguito il sorgere di una specifica funzione aziendale, la quale avrebbe poi trovato una sua definita collocazione organizzativa. A sorreggere quella idea era, di fatto, l'esperienza iniziata negli anni 90 del controllo di gestione con il suo percorso di sviluppo e consolidamento. Il controllo di gestione, come l'OM, aveva, infatti, rappresentato l'emergere di una razionalità, quella legata al consumo e utilizzo delle risorse, fino ad allora compressa dalle tre dimensioni che tradizionalmente dominavano il funzionamento delle aziende sanitarie pubbliche: la dimensione politica e del consenso, la dimensione amministrativa e della legalità, la dimensione clinica e dei risultati in termini di salute. Una serie di condizioni, tra cui la disponibilità di saperi e strumenti in un contesto di crescente legittimazione della dimensione economica, questa frutto dell'aziendalizzazione, avevano consentito una rapida diffusione di logiche e funzioni. Tale diffusione aveva a sua volta accelerato lo sviluppo dei saperi e delle pratiche legate ai meccanismi di governo economico nelle aziende sanitarie pubbliche. Le attese per l'OM erano, quindi, di un rapido superamento della "fase sperimentale", nella quale esperienze maturate in altri contesti organizzativi trovassero i necessari adattamenti, e, quindi, una

diffusione nelle aziende segnata da "ancoraggi organizzativi" sufficientemente definiti e dalla costituzione di una comunità sufficientemente ampia di professionisti specializzati.

L'idea che la gestione operativa potesse replicare la storia del controllo di gestione era evidentemente sbagliata: iniziare a riflettere brevemente su ciò la rende differente può aiutare a collocare meglio le esperienze analizzate e fornire alcune indicazioni su come accompagnarne più efficacemente la diffusione. In questa prospettiva, vale la pena porre l'attenzione su almeno quattro elementi.

Il primo, probabilmente il più rilevante, è l'oggetto sul quale l'OM interviene. Mentre il controllo di gestione opera prevalentemente all'esterno della clinica, adottando una logica *black box* che guarda solo alle risorse e ai risultati, la razionalità operativa interviene sui processi, confrontandosi direttamente con decisioni e responsabilità professionali e di linea. Tale circostanza è ricca di implicazioni a partire da confini più sfumati rispetto alle aree di intervento presidiabili dalla funzione fino ai rischi di sovrapposizione e conflitto con le linee gestionali e professionali. In altri termini la razionalità operativa, rispetto a quella economica, è più difficilmente separabile dalla gestione vera e propria ed è quindi più complicato affidarne il presidio prevalente a una specifica funzione.

La stessa stretta interazione con la gestione può essere letta in termini di continuità e permanenza del ruolo svolto nel contesto aziendale. Semplificando eroicamente, si può notare come il controllo di gestione eserciti stabilmente una medesima funzione, aiutato in questo dalla sua identificazione con un processo ciclico e permanente, dotato di strumenti specifici, come quello del budget. Il ruolo aziendale dell'OM, e la conseguente configurazione organizzativa, è molto più variegato e mutevole. In alcuni casi può essere quello, temporaneo e discontinuo, relativo alla gestione di singoli progetti di innovazione che una volta realizzati trasferiscono alla gestione corrente nuove capacità e modalità di funzionamento. In altri diventa il contenitore stabile di un insieme di progetti che assumono un loro significato complessivo e si costituisce come punto di riferimento per tutta l'azienda sui temi della razionalità operativa. In altri ancora assume la configurazione e le responsabilità tipiche di una unità di staff che presidia ben definiti meccanismi operativi. Si può arrivare, infine, alla assunzione di responsabilità di linea su aree di operazioni, anche molto ampie.

Il terzo attiene allo scenario organizzativo nel quale la diffusione della gestione operativa è stata chiamata a trovare i propri percorsi. Il ciclo di diffusione del controllo di gestione ha avuto luogo in un contesto relativamente semplice, caratterizzato da unità operative monodisciplinari, da una scarsa articolazione verticale (strutture piatte), da limitate funzioni di standardizzazione, al punto che per lungo tempo e in molte realtà il controllo di gestione rappresentava l'unica, omnicomprensiva, struttura di staff. Da alcuni lustri la

situazione è cambiata: lo scenario organizzativo è diventato più complesso e variegato, le linee e gli staff si sono moltiplicati, ma, soprattutto, la separazione tra nuclei operativi e organi di staff e, di coordinamento in generale, è diventata meno netta e spesso confusa. Da questo punto di vista, un buon esempio è rappresentato dalle le cosiddette piattaforme (blocchi operatori, ambulatori, …) le quali assumono la razionalità operativa, e non il tradizionale sapere clinico, come propria ragion d'essere. In questo caso è lecito chiedersi quale potrebbe essere il ruolo di una funzione specializzata in OM, se abbia senso che esista in quanto tale o se ad essa dovrebbero essere affidate tutte le attività "piattaformizzabili".

Il quarto è l'intensità e la natura degli stimoli che spingono le aziende a investire economicamente e organizzativamente per aumentare la loro efficienza operativa. Le spinte che l'ambiente ha esercitato affinché le aziende si dotassero di adeguati sistemi di controllo economico sono state molto intense non solo dal punto di vista istituzionale e dei meccanismi di finanziamento, ma anche dal punto di vista culturale: il controllo di gestione e la sua formalizzazione hanno rappresentato, infatti, il simbolo dell'aziendalizzazione. Le stesse spinte, inoltre, si distribuivano uniformemente su tutto il sistema aziendale: era l'insieme dell'azienda ad essere chiamata a rispondere. Le forze che hanno alimentato la diffusione di meccanismi e strumenti di gestione operativa hanno avuto caratteristiche profondamente diverse. Sul piano dell'intensità è sufficiente notare come la spinta a "produrre di più" (un migliore sfruttamento degli asset fisici) non sia sempre compatibile con i vincoli e gli incentivi tipici dei sistemi a finanziamento forfettario che pongono un limite alle risorse consumabili (tetti di spesa), mentre quella a "produrre meglio" non riesce a produrre stimoli equivalenti. Bisogna, inoltre, notare come il tema dell'efficienza operativa difficilmente viene avvertito come problema dell'azienda nel suo insieme. Solo alcune specifiche aree sono investite e vengono considerate target elettivi per le nuove logiche e i nuovi strumenti.

Come già accennato le considerazioni fin qui esposte possono aiutare a valutare meglio le esperienze analizzate. Se il quadro che si ricava dalla lettura è quello di una rilevante eterogeneità delle esperienze, con gradi di strutturazione e di maturità diversi, caratterizzate, in molti casi, da ambiguità nel posizionamento organizzativo, è possibile che tutto ciò non rifletta necessariamente una difficoltà nei processi di diffusione delle logiche e degli strumenti di gestione operativa e segnali quindi una debolezza delle aziende. Una strutturazione più debole e, a prima vista, confusa potrebbe essere la forma fisiologica che la penetrazione e lo sviluppo di una nuova dimensione della gestione assume.

Per il management questo vuol dire che il problema di un incremento deciso dei livelli di razionalità operativa non può essere semplicemente risolto strutturando una nuova funzione aziendale, magari prescritta a livello regionale, ma che necessita, da una parte, di una visione e di una strategia organizzativa

conseguente (individuazione di un mix adeguato di strutture, allocazione di responsabilità e strumenti) e, dall'altra, una costante capacità di governo delle ambiguità e sovrapposizioni che caratterizzano inevitabilmente ogni intervento sulla dimensione operativa.

Per chi fa ricerca e prova a offrire interpretazioni, possibilmente utili, di ciò che avviene nelle aziende, le implicazioni sono quelle relative a un fenomeno che necessita di essere guardato in prospettive diverse da quelle tradizionali. Dopo aver finora esplorato il fenomeno attraverso la chiave della strutturazione organizzativa, le ricerche future dovranno concentrare maggiormente l'attenzione sui contenuti della dimensione operativa e su come questi possano esprimersi in configurazioni e assetti diversi e permeare, così, il concreto funzionamento delle aziende.

18.8 Bibliografia

Belvedere V. (2013), «Defining the scope of service operations management: An investigation on the factors that affect the span of responsibility of the operations department in service companies», *Production Planning & Control*, 25(6), pp. 447-461.

Bensa G., Prenestini A., & Villa S. (2008), «La logistica del paziente in ospedale: aspetti concettuali, strumenti di analisi e leve di cambiamento», in CERGAS (a cura di), Rapporto OASI 2008, Milano, Egea, pp. 327-363.

Davies C., Walley P. (2000), «Clinical governance and operations management methodologies», *International Journal of Health Care Quality Assurance*, 13(1), pp. 21-26.

Del Vecchio M., Roma I. (2012), «L'operations management come innovazione gestionale», *Mecosan*, 21(81), pp. 27-46.

Fenech L., Lega F., & Prenestini A. (2017), «Il grado di diffusione di una funzione strutturata di gestione operativa nelle aziende sanitarie del SSN: un'analisi empirica», in CERGAS (a cura di), *Rapporto OASI 2017*, Milano, Egea.

Fenech L., Lega F., & Prenestini A. (2018), «L'Operations Management nelle aziende pubbliche del SSN: da work in progress a work on process», in CERGAS (a cura di), *Rapporto OASI 2018*, Milano, Egea.

Fenech L., Ferrara L., Hiedemann A., & Tozzi V. (2020), «L'offerta ambulatoriale per la popolazione cronica tra governo clinico e gestione operativa», in CERGAS (a cura di), *Rapporto OASI 2020*, Milano, Egea.

Fenech L., L'Operation management come fattore critico Economia & Management, 2022, no. 2, pp.17-21

Giusepi I., Lega F., Villa S. (2012), «Gli assetti organizzativi a supporto della gestione operativa: esperienze a confronto», in Cantù E. (a cura di),

L'aziendalizzazione della sanità in Italia. Rapporto OASI 2012, Milano, Egea, pp. 439-460.

Johnston R., Shulver M., Slack N. & Clark G. (2021), *Service operations management*, Quinta Edizione, Pearson Education.

Karuppan C. M., Dunlap N. E., & Waldrum M. R. (2021), *Operations management in healthcare: strategy and practice*, New York, Springer Publishing Company.

Langabeer J. R. II, & Langabeer J. R. (2008), *Health care operations management: a quantitative approach to business and logistics*, Sudbury, Jones & Bartlett Learning.

Litvak E., Long M.C. (2000), «Cost and quality under managed care: Irreconcilable differences? », *Am J Managed Care,* 6:305–312.

Mintzberg H. (1992), Structure in Fives: Designing Effective Organizations, Pearson.

Pellegrino R., Marsilio M., Prenestini A., & Villa S. (2024), «Le traiettorie di sviluppo della funzione di gestione operativa nelle aziende sanitarie italiane: evidenze dal caso lombardo», *Mecosan*, 131, pp. 33-55.

Secchi R. (2025), «Supply chain e operations manager-protagonisti o comparse?: Dieci esperienze esemplari», Milano, Egea.

Slack N., Brandon-Jones A., & Johnston R. (2019), «Operations Management», 9ª ed., Harlow, Pearson.

Sutton L., Tarrant C., Willars J., Coats T., Simmonds M., Mclean D., & Roland D. (2025), «How do staff work in NHS hospital operations management meetings to support resilience in everyday service delivery? A qualitative study», *BMC Health Services Research*, 25(1), pp. 113.

Villa S. (2021), «Operations Management for Healthcare Organizations: Theory, Models and Tools», London, Routledge.

Vissers J. M., Bertrand J. W. M., & De Vries G. (2001), «A *framework* for production control in health care organizations», *Production Plan*

Vissers J. M. & Beech R. (2005), «Health Operations Management: Patient Flow Logistics in Health Care», Routledge Management Series.